



SVPMUN
IV EDITION

APA

GUÍA ACADÉMICA



CARTA DE LA MESA DIRECTIVA:

¡Saludos delegados! Como su Mesa Directiva, para nosotras es un honor acompañarlos, guiarlos y ser partícipes de sus intervenciones durante los tres días de debate de la IV Edición del Modelo de Naciones Unidas del Colegio “San Vicente de Paúl”. Nuestra más grande recomendación es que lean, indaguen y siempre busquen más conocimiento, ya que lo que aprendan en su preparación y durante el modelo es el premio más valioso que pueden obtener de esta experiencia. Sabemos que tendrán un excelente desempeño, tenemos altas expectativas en ustedes, así que investiguen y prepárense lo mejor que puedan para este interesante tópico. Sin mucho más que acotar, les agradecemos por tomar la oportunidad de inscribirse y participar en este comité, ¡y les deseamos los mayores éxitos durante esta edición de SVPMUN! Nos vemos pronto.

Presidente
Miranda Pérez

Vicepresidente
Sara Riera

Asesor Académico
Prof. Henry Camacho



I. INTRODUCCIÓN

La Asociación Americana de Psicología (APA) se consolidó como la organización profesional más importante de esta disciplina en los Estados Unidos. Sus orígenes se remontan a julio de 1892, cuando un grupo inicial de profesionales se reunió en el estudio de G. Stanley Hall en la Universidad Clark para sentar las bases de una nueva comunidad científica. Con el paso de los años, la institución creció de manera constante hasta estructurar un sistema interno sólido que coordina su labor a nivel nacional. Desde su sede principal en Washington, D.C., la APA mantiene una colaboración estrecha con diversos organismos gubernamentales y científicos de alta relevancia, tales como los Institutos Nacionales de Salud, la Academia Nacional de Medicina y la Fundación Nacional de Ciencias.

En este sentido, el propósito principal de la organización consiste en promover la creación, el desarrollo y la aplicación práctica del conocimiento psicológico para beneficiar a la sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas. Para cumplir con esta meta, la institución impulsa la investigación científica mediante la mejora de métodos y condiciones de estudio. Asimismo, establece estándares rigurosos de ética, conducta y formación profesional para asegurar la utilidad de los especialistas en el área. Para respaldar estas acciones, la APA se encarga de difundir el conocimiento acumulado a través de reuniones periódicas, contactos profesionales, informes y publicaciones especializadas.

Para cumplir con estos objetivos, la APA destaca por su diversidad y sus múltiples divisiones especializadas. Estas agrupaciones surgieron de la necesidad académica de debatir tanto cuestiones teóricas como problemáticas sociales y clínicas relevantes. Si bien las primeras divisiones se centraron en la ciencia básica, el crecimiento institucional permitió incorporar ramas aplicadas para abordar profesionales, poblaciones y contextos concretos. Esta evolución refleja el proceso de maduración de la disciplina, el cual ha resultado indispensable para estructurar marcos teóricos y herramientas de diagnóstico precisas frente a desafíos clínicos de alta complejidad, como las secuelas disociativas y psicopatológicas derivadas del trauma severo.



1.- DINÁMICA DEL COMITÉ

El comité operará bajo la estructura de una junta de expertos de la Asociación Americana de Psicología (AAPA), cuyo propósito central es promover la aplicación práctica del conocimiento científico frente a desafíos clínicos de alta complejidad, ya sean con respecto al análisis de cuadros clínicos o análisis de posibles reestructuraciones de los manuales nosológicos que rigen la disciplina científica. Durante las sesiones, los delegados asumirán el rol de especialistas encargados de evaluar y debatir sobre las secuelas disociativas y psicopatológicas derivadas del trauma severo, así como de la eficacia de los actuales manuales diagnósticos frente a estos casos específicos. Por consiguiente, y en aras de garantizar el rigor científico que caracteriza a este comité, todas las deliberaciones y participaciones se regirán bajo el marco metodológico de las directrices de práctica profesional de la AAPA.

Con este propósito, la dinámica en las sesiones del comité exigirá que los delegados analicen y discutan expedientes y casos clínicos proporcionados por la mesa directiva. Es importante resaltar que, como especialistas miembros de la Asociación Americana de Psicología, su deber no será catalogar al sujeto del estudio de caso dentro de un diagnóstico clínico, ya que establecer y afirmar un diagnóstico clínico específico requiere un proceso sistemático de evaluación rigurosa que combine la interacción directa, la observación y el uso de herramientas estandarizadas.

En su lugar, la labor de los especialistas será construir un análisis clínico integral que trascienda la etiqueta reduccionista. Se espera que los especialistas analicen los patrones sintomatológicos, la etiología del trauma y el contexto sociocultural de los expedientes, además de contrastar estas manifestaciones con los criterios diagnósticos actuales de los manuales nosológicos para evidenciar sus posibles fallas o limitaciones empíricas. En última instancia, los especialistas asumirán la responsabilidad de proponer lineamientos de intervención integral y la redacción de recomendaciones formales dirigidas al Steering Committee del DSM (American Psychiatric Association) y a la División de Salud Mental de la OMS (responsable de la CIE-11), garantizando que el abordaje de las secuelas disociativas refleje verdaderamente la complejidad de la experiencia humana y no una mera categorización reduccionista.

Paralelamente, los especialistas deberán realizar un análisis etiológico riguroso para sopesar cada caso, cuidando de no atribuir erróneamente la severidad de una patología grave a lo que podría constituir una respuesta adaptativa



transitoria. A partir de esto, será indispensable distinguir con precisión si la presentación clínica del paciente evidencia una sintomatología compatible con un trauma de incidente único, o si, por el contrario, responde a los estragos de una victimización sostenida en el tiempo.

Durante este proceso de correlación clínica, los profesionales tendrán la obligación de evaluar el impacto directo que ejercen la opresión sistémica, la discriminación y la violencia estructural sobre la salud mental del individuo. Esto implica el deber de prevenir sesgos occidentales, evitando imponer marcos teóricos rígidos y reconociendo que el trauma puede expresarse mediante manifestaciones somáticas, neurocognitivas o lenguajes espirituales que de ninguna manera deben ser descartados. A su vez, al analizar la información anamnésica, los expertos deberán mapear la trayectoria de adversidad sufrida por el sujeto a lo largo de todo su ciclo vital y desarrollo evolutivo, superando el registro limitado de eventos aislados en el presente. Para lograrlo, será un requisito metodológico ineludible comprender que los relatos derivados del trauma complejo suelen presentarse de manera fragmentada y sin una secuencia cronológica clara debido a factores neurobiológicos, característica que bajo ninguna circunstancia deberá utilizarse para cuestionar la veracidad del testimonio del paciente.

A lo largo del desarrollo del comité, los especialistas tendrán el deber de fundamentar todas sus observaciones empleando los anexos técnicos facilitados por la mesa directiva. El objetivo definitivo de la simulación no será emitir sentencias médicas o diagnósticos concluyentes, sino establecer asociaciones empíricas fundamentadas, es decir, concluir y argumentar que el individuo muestra sintomatología compatible con determinados cuadros nosológicos. De tal manera, se busca estructurar impresiones clínicas que trasciendan la simple asignación de etiquetas superficiales, capturando de forma integral la desregulación afectiva del sujeto y garantizando que la evaluación final refleje fielmente la complejidad de su contexto sociocultural.

Aunado a lo anterior, la dinámica del comité poseerá un carácter evolutivo y continuo. La mesa directiva se reserva el derecho de introducir actualizaciones clínicas progresivas, tales como nuevos hallazgos en el historial del paciente, resultados de evaluaciones psicológicas complementarias o giros en el contexto psicosocial del caso en estudio. Estas intervenciones exigirán que los delegados demuestren adaptabilidad analítica, obligándolos a reevaluar sus impresiones clínicas preliminares y a ajustar sus estrategias de abordaje terapéutico en tiempo real frente a nueva evidencia.



Por otra parte, es imperativo destacar que toda deliberación y propuesta de intervención deberá estar anclada firmemente en los Principios Éticos de los Psicólogos y el Código de Conducta de la APA. Los especialistas deberán garantizar en todo momento los principios de beneficencia y no maleficencia, asegurando que cualquier reestructuración nosológica debatida no genere estigmatización ni patologice reacciones naturales a entornos hostiles. El debate deberá sostenerse sobre la premisa fundamental de hacer el menor daño posible y proteger la integridad, dignidad y confidencialidad inherente a las poblaciones vulnerables.

Para concluir todo lo debatido en las sesiones de trabajo, deberá materializarse en la redacción de un Documento de Consenso Clínico. En este, las distintas coaliciones de expertos plasmarán sus hallazgos fenomenológicos, estructurarán las propuestas formales para la modificación o adición de criterios en los manuales nosológicos vigentes y establecerán directrices terapéuticas y éticas para el abordaje del trauma complejo del caso. Este producto final deberá reflejar no solo el acuerdo mayoritario del comité, sino también el rigor científico y la viabilidad empírica de las reestructuraciones propuestas en el futuro. Con el fin de enriquecer la calidad del debate y sustentar estas modificaciones, resulta clave atender las siguientes consideraciones:

2.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Antes de iniciar el análisis de cualquier expediente clínico, resulta indispensable que los especialistas del comité comprendan con precisión los instrumentos que sustentarán sus deliberaciones a lo largo de las sesiones. Estas herramientas cumplen funciones distintas pero complementarias, los manuales diagnósticos ofrecen el marco normativo bajo el cual se formulan las asociaciones empíricas, mientras que las fichas clínicas constituyen la fuente primaria de información sobre la cual dicho marco debe aplicarse. Un manejo deficiente de cualquiera de estos elementos comprometería directamente la calidad del debate, dado que los especialistas estarían argumentando sobre una base normativa incompleta o interpretando el expediente clínico sin el rigor metodológico que el comité exige.

- **Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, texto revisado (DSM-5-TR)**

El DSM-5-TR es publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría y constituye el sistema de clasificación categórico de los trastornos mentales más empleado dentro de la práctica clínica y la investigación en salud



mental, particularmente en Estados Unidos (American Psychiatric Association, 2022). El manual define cada trastorno mediante un conjunto explícito de criterios diagnósticos, especificando el número mínimo de síntomas requeridos dentro de cada conglomerado sintomático, el umbral temporal necesario para alcanzar el diagnóstico y los criterios de exclusión que permiten descartar otras condiciones médicas o el efecto de sustancias como origen del cuadro clínico. Esta estructura categórica busca ofrecer un lenguaje común y estandarizado entre clínicos e investigadores, permitiendo que un mismo diagnóstico sea identificado de manera consistente a través de distintos entornos profesionales.

Por otro lado, en cuanto a su organización interna, el mencionado manual sigue un formato relativamente uniforme que resulta fundamental conocer para aprovechar correctamente el manual. Tras el listado explícito de los criterios diagnósticos, identificados habitualmente mediante letras consecutivas, el manual desarrolla apartados adicionales sobre las características diagnósticas, las características asociadas que apoyan el diagnóstico, la prevalencia, el desarrollo y curso del trastorno, los factores de riesgo y pronóstico, las cuestiones diagnósticas relacionadas con la cultura y el género, y un apartado de diagnóstico diferencial que resulta especialmente relevante para el trabajo del comité.

- **Clasificación Internacional de Enfermedades, Undécima Revisión (CIE-11)**

La CIE-11 fue publicada por la Organización Mundial de la Salud y entró en vigor oficialmente en enero de 2022, constituyendo el sistema de clasificación de referencia a nivel internacional. A diferencia del DSM-5-TR, este manual se desarrolló mediante un formato denominado Descripciones Clínicas y Directrices Diagnósticas, el cual describe las características esenciales de cada trastorno junto con un conjunto de características adicionales que apoyan, sin exigir de manera rígida, el diagnóstico. Este diseño otorga al clínico un margen mayor de juicio profesional, aspecto que conviene que los especialistas del comité tengan presente al momento de argumentar sus impresiones clínicas bajo este sistema, dado que la ausencia de un algoritmo numérico exacto exige una justificación cualitativa más elaborada por parte de quien invoca el diagnóstico.

Para efectos de consulta práctica, la Organización Mundial de la Salud mantiene disponible el navegador oficial de la CIE-11 en línea, el cual permite acceder directamente al componente denominado Fundación, donde se



detallan de forma exhaustiva las características esenciales y adicionales de cada entidad diagnóstica, así como sus límites frente a trastornos relacionados.

3.- LIMITACIONES EN LA DISTINCIÓN DE PERFILES SINTOMÁTICOS MEDIANTE LOS CRITERIOS ACTUALES DE TRASTORNOS

Uno de los mayores retos dentro del ámbito de la psicología clínica radica en la profunda discrepancia entre los manuales de diagnóstico y la experiencia clínica real de los pacientes que sufren trastornos mentales. Los sistemas de clasificación como el DSM-5 asumen que un conjunto específico de síntomas define un trastorno único y diferenciable. Este enfoque presupone que (i) los grupos específicos de síntomas son eficaces para diferenciar a los individuos según su perfil sintomático, de modo que las personas con un diagnóstico particular presentan síntomas similares, y (ii) que estos grupos diagnósticos basados en síntomas comparten una etiología subyacente común. No obstante, la evidencia científica demuestra que existe una altísima heterogeneidad sintomática y una comorbilidad masiva tanto dentro de un mismo diagnóstico como entre diferentes categorías clínicas (Newson et al., 2021).

Con respecto a esto, investigaciones recientes sobre perfiles psicopatológicos señalan que las combinaciones posibles de síntomas para alcanzar un diagnóstico clínico son sumamente diversas. Por ejemplo, se estima que existen hasta 636.120 combinaciones posibles de síntomas capaces de cumplir con los criterios para un diagnóstico de Trastorno de Estrés Postraumático (Galatzer-Levy & Bryant, 2013), y 227 formas posibles de satisfacer un diagnóstico de depresión mayor (Zimmerman et al., 2015), lo que refleja una variabilidad intra-diagnóstica considerable. De igual forma, los pacientes presentan una alta propensión a la comorbilidad entre múltiples trastornos del DSM-5, siendo frecuente que un individuo cumpla con los criterios para varios diagnósticos simultáneamente y que la trayectoria y evolución de los trastornos a lo largo de la vida constituyen un fenómeno generalizado.

Bajo esta misma perspectiva, dicha premisa encuentra respaldo en un que examinó el problema de forma directa. La investigación desarrollada por Newson, Pastukh y Thiagarajan (2021), titulada "Poor Separation of Clinical Symptom Profiles by DSM-5 Disorder Criteria", profundiza en la variabilidad y el solapamiento sintomático previamente señalados, ofreciendo una demostración cuantitativa de por qué los criterios normativos actuales fallan en la práctica. La hipótesis central sostiene que los sistemas de clasificación diagnóstica tradicionales,



específicamente el DSM-5, carecen de la especificidad necesaria para separar de manera empírica a los individuos en grupos clínicos distintos basándose en sus perfiles de síntomas. Por consiguiente, los autores postulan que la heterogeneidad sintomática y la **comorbilidad** masiva dentro y entre los trastornos psiquiátricos son tan elevadas que las etiquetas diagnósticas categóricas fallan en reflejar la realidad clínica de los pacientes. A partir de esto, se plantea que la utilización de criterios estrictamente basados en conjuntos predeterminados de síntomas genera una desalineación fundamental entre los manuales normativos y la manifestación real del sufrimiento psíquico.

En cuanto al diseño metodológico, los investigadores ejecutaron un estudio cuantitativo a gran escala utilizando datos obtenidos a través del Mental Health Quotient, una herramienta de evaluación en línea de autorreporte completada de forma anónima por una muestra masiva de 107,349 adultos en ocho países de habla inglesa. En este sentido, el procedimiento consistió en mapear 47 elementos de salud mental evaluados por dicha herramienta directamente con los criterios diagnósticos del DSM-5 para diez de los trastornos más comunes, abarcando desde la depresión hasta el estrés postraumático. Por lo tanto, el análisis computacional posterior calculó las medidas de disimilitud y la distribución de los perfiles sintomáticos para contrastar estadísticamente la variabilidad interna de los grupos diagnósticos frente a las diferencias entre grupos y muestras aleatorias.

Con respecto a los resultados, las conclusiones alcanzadas por el equipo de investigación validaron plenamente la hipótesis inicial planteada al demostrar una profunda superposición y una falta de separación empírica entre los trastornos evaluados. En consecuencia, el estudio reveló que más de la mitad de las personas con síntomas clínicamente significativos no encajan en los criterios de ningún trastorno aislado del DSM-5, mientras que aquellos que sí cumplen con una etiqueta presentan, en promedio, una veintena de síntomas graves simultáneos. Por ende, los autores comprobaron que la heterogeneidad de los perfiles sintomáticos dentro de una misma categoría diagnóstica es tan alta que resulta indistinguible de una agrupación aleatoria de individuos con cualquier condición clínica.

Tales hallazgos evidencian que dicha variabilidad plantea desafíos sustanciales al momento de evaluar las fichas clínicas, los cuales deben ser rigurosamente considerados y abordados en el debate por los especialistas. En el marco del comité, el análisis de un expediente clínico requiere ir más allá de la dependencia absoluta a las clasificaciones normativas del DSM-5, sobre todo cuando estas no ofrecen la especificidad requerida para aprehender la complejidad



del perfil individual. Por ello, los especialistas asumen la responsabilidad de señalar las limitaciones emergentes cuando los criterios preestablecidos fijan categorizaciones rígidas ante cuadros sintomáticos altamente complejos, siempre y cuando se apoyen en bases académicas y empíricas sólidas.

II. DIRECTRICES DE LA APA PARA PSICÓLOGOS EN LA EVALUACIÓN DEL TRAUMA PSICOLÓGICO EN ADULTOS

Para efectos y alcances de este comité, las deliberaciones y las participaciones de los expertos se verán regidas bajo las directrices de práctica profesional de la APA. Publicadas oficialmente por la institución en agosto de 2025, tienen el objetivo de proporcionar un marco metodológico de referencia para aquellos profesionales que prestan, supervisan y capacitan en la provisión de servicios psicológicos, independientemente del entorno clínico, forense o institucional en el que operen. Asimismo, su diseño busca guiar a la comunidad científica en el análisis de cómo los antecedentes de trauma crónico y complejo elevan la dificultad de los casos, impactan la precisión de las pruebas psicométricas y definen el rumbo de la intervención terapéutica.

DIRECTRIZ 1.

El trauma como posible etiología de los problemas de presentación habituales.

De acuerdo con esta directriz, la escasez de formación especializada en trauma conduce a los evaluadores a cometer errores de valoración en direcciones opuestas (Cook et al., 2014; Simiola et al., 2018). En un extremo, se atribuye una gravedad excesiva a reacciones de ansiedad o a alteraciones del sueño que surgen tras un evento único, cuando en realidad suelen tratarse de respuestas transitorias que remiten por sí solas con el paso del tiempo (Galatzer-Levy et al., 2018). En el extremo opuesto, se resta importancia a las consecuencias del trauma repetido, la marginación y la escasez de apoyo social, factores que sí generan un malestar crónico y de mayor profundidad (Eadie & Briere, 2025; Nadal, 2018).

Por otra parte, las manifestaciones clínicas graves del trauma, como los trastornos disociativos o los cuadros depresivos severos, no siempre emergen de forma inmediata. Con frecuencia permanecen latentes durante años y solo se activan ante un nuevo desencadenante que interactúa con vulnerabilidades previas o con contextos de opresión sistémica (Carlson et al., 2017; Mandelli et al., 2015). El trauma vivido en la infancia repercute además de manera distinta sobre la



regulación emocional y la capacidad de vincularse, en comparación con el trauma agudo ocurrido en la adultez (Brewin et al., 2017). Reconocer esta diferencia evita diagnósticos apresurados y permite ubicar con mayor precisión el origen del malestar (Stanton et al., 2020).

En este mismo orden de ideas, la escasez de investigación centrada en poblaciones vulnerables y marginadas impide establecer con certeza si estos hallazgos se generalizan a personas que enfrentan exposiciones repetidas a traumas insidiosos, como las distintas formas de opresión estructural y sistémica (APA, 2017b; Nadal, 2018). Los efectos del trauma pueden además transmitirse de forma intergeneracional, un fenómeno que tiende a reforzarse cuando la opresión sistémica se sostiene a lo largo del ciclo vital de una familia o comunidad (Nagata et al., 2024; APA, 2017c).

También conviene señalar que determinadas variables se vinculan de manera constante con un mayor riesgo de desarrollar trastorno de estrés postraumático, entre ellas los trastornos psiquiátricos preexistentes y la exposición previa a violencia interpersonal. A estas se suman los antecedentes familiares de trastornos psiquiátricos, que igualmente elevan dicho riesgo (Carlson et al., 2017). A pesar de la relevancia de estos indicadores, se ha observado que los propios profesionales tienden a subregistrar los antecedentes traumáticos de la persona evaluada, lo cual agrava la probabilidad de un error diagnóstico (Nagar et al., 2020).

Desde una perspectiva histórica, Herman (1992) advirtió que la formulación clásica del trastorno de estrés postraumático, construida a partir de sobrevivientes de eventos relativamente circunscritos, resultaba insuficiente para capturar las secuelas de un trauma prolongado y repetido. Esta observación dio origen al concepto de trauma complejo, posteriormente incorporado en la Clasificación Internacional de Enfermedades bajo la categoría de perturbaciones en la autoorganización, que abarca la desregulación afectiva, el autoconcepto negativo y las dificultades relacionales (Cloitre et al., 2014). Disponer de este marco permite al comité distinguir con mayor precisión entre una presentación compatible con un trauma de incidente único y una que responde a una historia de victimización sostenida en el tiempo.

Aplicación

Al momento de emitir sus deliberaciones, los especialistas deben emplear este conocimiento sobre el curso natural del trauma para sopesar con rigor clínico cada caso, evitando clasificar erróneamente como patología grave una respuesta adaptativa transitoria, o bien restando peso a una lesión psicológica crónica.



Durante el proceso evaluativo, el profesional debe fundamentar su valoración determinando si el síntoma analizado responde al curso esperado de una reacción postraumática o si evidencia un trastorno profundo. Asimismo, en la formulación de las impresiones diagnósticas y las entrevistas iniciales, es un requisito metodológico indagar en historiales de victimización que aún no figuren en los expedientes oficiales. Esto garantiza que el diagnóstico no se limite a etiquetar el síntoma superficial de un evento aislado, sino que capture de forma integral la complejidad sintomática y las secuelas de la desregulación afectiva derivadas de una historia prolongada de adversidad.

DIRECTRIZ 2.

Contextualización sociocultural y opresión sistémica en la evaluación del trauma.

Justificación

Esta directriz parte de que los efectos del trauma se encuentran condicionados por el entorno cultural, el estatus identitario y las dinámicas de poder vigentes en la sociedad, de modo que su comprensión exige ir más allá del individuo aislado. La opresión sistémica, la discriminación institucional y las microagresiones cotidianas operan como formas insidiosas de trauma que elevan de manera significativa el riesgo de desarrollar un cuadro psicopatológico (APA, 2017b; Nadal, 2018). Cuando el evaluador pasa por alto estas variables, corre el riesgo de atribuir el malestar únicamente a una disfunción individual, dejando de lado el peso del entorno hostil sobre la persona evaluada (Botelho et al., 2022).

Adicionalmente, conviene notar que la respuesta a la opresión no siempre encaja en las categorías diagnósticas convencionales. La intersección entre el género y el origen étnico o racial, junto con la clase social y la edad, produce una carga acumulativa de estrés crónico que erosiona los recursos de afrontamiento del paciente y modifica sus supuestos básicos sobre la seguridad del entorno que lo rodea (Eadie & Briere, 2025).

Cabe destacar, además, que las formas de expresar el malestar varían considerablemente entre culturas. Una evaluación construida exclusivamente sobre tradiciones occidentales puede pasar por alto síntomas relevantes, como las quejas somáticas o las manifestaciones neurocognitivas, que resultan más frecuentes en buena parte de la comunidad global (Hinton & Lewis-Fernández, 2018). La propia definición de lo que constituye un acontecimiento traumático varía igualmente según el contexto cultural en el que se formule (Haering et al., 2024).



Por su parte, las personas provenientes de culturas no occidentales pueden experimentar el trauma dentro de condiciones ambientales crónicas y debilitantes, tales como la persecución política y el desplazamiento forzado derivado de conflictos o procesos migratorios. En estos casos no puede presuponerse una condición de normalidad previa al evento traumático, dado que la adversidad suele formar parte continua del entorno del paciente (Hoshmand, 2007).

En estrecha relación con lo anterior, los criterios actuales de los trastornos disociativos reconocen oficialmente la experiencia de posesión como una forma válida de fragmentación de la identidad (Spiegel et al., 2013). Esta incorporación demuestra que muchas culturas expresan el trauma mediante lenguajes religiosos o espirituales que forman parte real de la psicopatología y no deben descartarse como simples creencias ajenas a ella. Con este ajuste, la evaluación busca evitar imponer categorías occidentales rígidas que ignoren la cosmovisión del paciente.

Aplicación

Durante el proceso de formulación de sus participaciones, los profesionales deben integrar el impacto directo que la discriminación, la violencia estructural y el desplazamiento forzado ejercen sobre la salud mental, evitando atribuir el malestar únicamente a disfunciones individuales. Los expertos deben identificar con precisión, cuando resulte necesario, de qué manera la opresión sistémica altera los resultados de las pruebas psicométricas y la presentación clínica, previniendo sesgos discriminatorios en el diagnóstico oficial. Las conclusiones deben contemplar y reconocer las injusticias sistémicas como detonantes estructurales válidos de daño psíquico, asegurando que la evaluación refleje fielmente el contexto sociopolítico del paciente.

DIRECTRIZ 3.

Evaluación integral de la historia de victimización a lo largo del ciclo vital.

Esta directriz sostiene que la evaluación clínica del trauma requiere mapear de forma exhaustiva la trayectoria de adversidad que el paciente ha enfrentado a lo largo de toda su vida, superando el registro limitado de un evento aislado en el presente (Felitti et al., 2019). La evidencia empírica confirma una relación de acumulación consistente entre el número de experiencias traumáticas sufridas desde la infancia hasta la adultez y la severidad sintomática, la probabilidad de comorbilidad psiquiátrica y el deterioro funcional del paciente (Brewin et al., 2017; Duchowny et al., 2025).



Cabe agregar que el trauma complejo acumulado altera de forma duradera la autoorganización del individuo y su regulación afectiva. A ello se suma un impacto igualmente duradero sobre sus patrones de apego (Brewin et al., 2017). Los pacientes suelen enfrentar, sin embargo, barreras para reportar su historial completo, entre las que destacan el estigma y la vergüenza asociados a la revelación. También incide de forma considerable la fragmentación propia de la memoria traumática (Brand, 2024). Cuando el profesional omite una revisión retrospectiva del ciclo vital, pierde de vista el factor explicativo principal de los cuadros clínicos más complejos.

Resulta pertinente añadir que incluso los eventos traumáticos ocurridos en un pasado distante, o dentro de la historia familiar, pueden seguir influyendo en el bienestar actual del paciente. Este fenómeno se observa, por ejemplo, en los antecedentes de trauma infantil no resuelto que persisten hasta la adultez, así como en descendientes de sobrevivientes de acontecimientos históricos de gran magnitud, en quienes la transmisión intergeneracional del trauma puede seguir manifestándose (Nagata et al., 2024).

Desde una perspectiva neurobiológica, van der Kolk (2014) sostiene que la experiencia traumática queda inscrita tanto en la memoria narrativa como en el propio cuerpo, lo que explica por qué muchos relatos de trauma se presentan de forma fragmentada y sensorial, desprovista de una secuencia cronológica clara. Esta característica resulta especialmente relevante al reconstruir una historia de victimización extendida a lo largo del ciclo vital, dado que el paciente puede tener dificultades genuinas para ordenar temporalmente los distintos episodios traumáticos que ha atravesado.

Aplicación

Los especialistas tienen el deber de emplear los anexos técnicos facilitados por la Mesa Directiva para implementar herramientas y recibir información que permitan identificar la cronicidad y recurrencia de experiencias adversas previas. Es indispensable que realicen una indagación exhaustiva de la trayectoria de victimización, tanto en la infancia como en la etapa adulta, trascendiendo el registro de un acontecimiento aislado al formular la impresión clínica definitiva. Del mismo modo, durante la fase de anamnesis, los profesionales deben considerar que el testimonio de un sobreviviente de trauma complejo difícilmente se estructurará de manera lineal; por consiguiente, resulta imperativo reconocer dicha fragmentación narrativa como un correlato neurobiológico previsto, evitando que se utilice para cuestionar la veracidad del relato.



III. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL TÓPICO

Resulta ineludible constatar que la mente humana representa el sistema más complejo, dinámico y adaptativo de la naturaleza. Lejos de ser un simple agente pasivo receptor de información, la psique opera como una estructura extremadamente activa cuyo propósito fundamental es la supervivencia, la autorregulación y la construcción de significado. Históricamente, el estudio de la mente ha representado uno de los mayores desafíos para las ciencias de la salud y el comportamiento. Desde los primeros postulados del psicoanálisis hasta los hallazgos contemporáneos en neurobiología, la ciencia ha intentado descifrar cómo el ser humano percibe, codifica su entorno, procesa sus emociones, construye e interpreta la realidad que lo rodea. Sin embargo, como humanidad aún nos encontramos lejos de comprender al cien por ciento el funcionamiento integral de la psique humana.

Exponiendo un ejemplo para intentar comprender la complejidad de la mente, diariamente el individuo se encuentra expuesto a un sinfín de estímulos que debe percibir, clasificar, evaluar, codificar y otorgarles sentido, todo esto de manera simultánea y casi automática. Desde sentir la tela de su ropa en su piel, hasta leer, procesar y otorgarle significado a las palabras que están leyendo en este momento en esta guía académica, todo lo anterior representa estímulos que contienen información que su mente debe “reducir, transformar, guardar, recuperar y utilizar, un proceso continuo más no secuencial” (Neisser, 1967) que Ulric Neisser en su libro Psicología Cognitiva menciona como **cognición**.

Ahora bien, la cognición no actúa de manera aislada, requiere de una arquitectura psíquica que otorgue continuidad a la experiencia vivida. Para lograrlo, la mente organiza la información en esquemas cognitivos y afectivos, los cuales son estructuras internas que funcionan como lentes o filtros perceptuales a través de los cuales el sujeto interpreta automáticamente su entorno, a los demás y a sí mismo. Para comprender su relevancia en la evaluación clínica, conviene contrastar cómo opera un esquema adaptativo frente a uno reconfigurado por la adversidad: Por ejemplo, en condiciones normativas, el individuo consolida esquemas de confianza y previsibilidad, ante una falla personal o un conflicto interpersonal, se activa una premisa implícita y casi inconsciente de que la situación es resoluble y no anula su valor como individuo ni su seguridad. A nivel afectivo, esto desencadena una respuesta fisiológica de calma relativa que permite desplegar estrategias adaptativas de resolución de conflictos. En contraposición, en contextos de trauma o de exposición a adversidad prolongada, la psique estructura esquemas de amenaza o traición inminente para protegerse del peligro. Frente a un estímulo



cotidiano y completamente neutro, por ejemplo una frase ambigua o un tono de voz firme, el esquema traumático se activa de forma automática antes de cualquier análisis racional (emocionalidad por encima de raciocinio). La mente interpreta la señal como un peligro inminente, desencadenando respuestas viscerales de hipervigilancia, culpa o desconfianza difusa, y obligando al sujeto a reaccionar mediante la paralización, la sumisión o la huida defensiva, respuestas que pueden considerarse desproporcionadas al estímulo no amenazante que las activa.

Para comprender con mayor rigor y bajo una perspectiva multiparadigmática, resulta esclarecedor acudir a la Teoría de los dos Sistemas de Pensamiento, la cual Daniel Kahneman populariza en su libro *Pensar rápido, pensar despacio* (2011) a partir del trabajo previo de Stanovich y West (2000) sobre el razonamiento dual. Kahneman postula que la arquitectura cognitiva se articula mediante dos modos de procesamiento: el Sistema 1, que es rápido, automático, emocional e implícito, y funciona con poco o ningún esfuerzo. Este modo de pensamiento permite tomar decisiones y emitir juicios rápidos basados en patrones y experiencias, como los esquemas mentales mencionados anteriormente. Luego está el Sistema 2, que es lento, deliberado, lógico, consciente y reflexivo, y requiere un esfuerzo intencional. Este tipo de pensamiento se utiliza para la resolución de problemas complejos y tareas analíticas que requieren mayor reflexión y consideración. Para asociar esta teoría con ejemplos de la cotidianidad en aras de comprender mejor sus conceptos, al leer una palabra, o resolver una suma simple como $2+2$, la respuesta surge al instante y sin esfuerzo alguno: esa es la operación automática del Sistema 1. En cambio, ante el requerimiento de calcular una ecuación más compleja o buscar a un conocido en medio de una multitud ruidosa, la mente debe pausar, enfocar la atención y realizar un procesamiento deliberado, utilizándose el Sistema 2.

Tabla 1

Estructura del modelo cognitivo de procesos duales (Sistema 1 frente a Sistema 2)

Dimensión epistemológica	Procesamiento tipo 1	Procesamiento tipo 2
Denominación técnica	Heurístico, asociativo, intuitivo o tácito.	Algorítmico, analítico, reflexivo o explícito.
Sustrato neuroanatómico	Estructuras subcorticales y sistema límbico (complejo amigdalino, ganglios basales).	Corteza prefrontal (dorsolateral y ventromedial).
Mediación autonómica	Predominio del Sistema Nervioso Simpático	Predominio del Sistema Nervioso Parasimpático



Mediación autonómica	Mínima o nula. Opera bajo un principio de economía cognitiva sin fatiga.	Elevada. Limitado por la capacidad de la memoria de trabajo y la glucosa cerebral.
Modo de operación	Automático, inconsciente, rápido y en procesamiento paralelo.	Controlado, consciente, lento y en procesamiento serial (secuencial).
Validez evolutiva	Filogenéticamente antiguo; compartido con otras especies para la supervivencia.	Filogenéticamente reciente; propio del desarrollo de la neocorteza humana.
Tipo de memoria asociado	Memoria implícita, procedimental y semántica asociativa.	Memoria explícita, declarativa y episódica (biográfica).
Dinámica ante el trauma	Hiperactivación funcional. En él se asume el control absoluto mediante respuestas subcorticales defensivas (lucha, huida, parálisis).	Inhibición funcional. En este existe desconexión por sobrecarga alostática, imposibilitando la narrativa lógica del suceso.

Nota. Adaptado de Thinking, fast and slow, por D. Kahneman, 2011, Farrar, Straus and Giroux; y de "Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate?", por K. E. Stanovich y R. F. West, 2000, Behavioral and Brain Sciences, 23(5), pp. 645-665.

En condiciones de homeostasis y de equilibrio psíquico, ambos sistemas cooperan de manera armónica: el Sistema 1 monitorea el entorno de forma continua para resolver las demandas automáticas de la cotidianidad, mientras que el Sistema 2 interviene como un supervisor estratégico únicamente cuando la novedad, el conflicto o la complejidad del estímulo demandan un análisis deliberado, y cuando se enfrenta una experiencia estresante o compleja, la psique logra procesarla, interpretarla y alojarla en componentes de la memoria, como la **memoria explícita o biográfica**. Es así como este suceso del que se habla se convierte en un relato con principio, desarrollo y fin en la vida del individuo, pasa a ser parte de la historia sin vulnerar la integridad del yo.

Empero, cuando la psique se enfrenta a una vivencia de amenaza abrumadora o trauma, esta dinámica de cooperación se altera drásticamente. Ante la percepción de un peligro inminente que compromete la integridad física o psicológica del sujeto, la prioridad biológica de la arquitectura cognitiva se desplaza de la construcción de significado a la supervivencia inmediata.

En este escenario crítico, se desencadena un predominio absoluto del Sistema 1, el cual activa respuestas evolutivas y subcorticales automáticas, usualmente asociadas al llamado cerebro reptil (tales como la lucha, la huida, la paralización o la sumisión). De forma simultánea, ocurre una inhibición funcional del Sistema 2, la cual responde a una economía y gestión de recursos adaptativa de la mente: el tiempo y los recursos requeridos para el análisis lógico, la evaluación narrativa y la verbalización consciente que realiza el Sistema 2 resultan excesivamente lentos ante una amenaza que exige una reacción defensiva en fracciones de segundo.

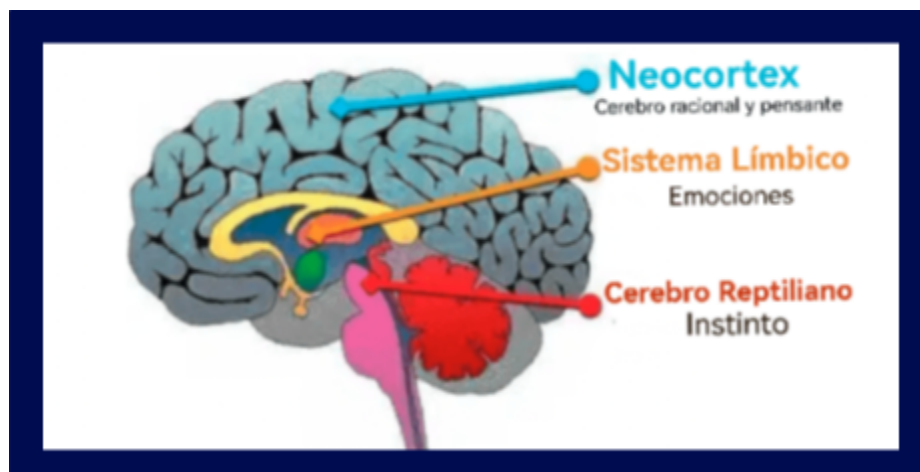
En este mismo hilo conductor, para ilustrar con mayor precisión anatómica esta jerarquía de respuesta, resulta pedagógicamente útil, aunque no exento de controversia científica, el modelo del cerebro triuno, propuesto por el neurocientífico Paul MacLean (1990). Este modelo divide heurísticamente al cerebro en tres estructuras que MacLean concibió como capas evolutivas sucesivas: el complejo reptiliano, encargado de funciones vitales básicas como la respiración y las reacciones instintivas de supervivencia; el sistema límbico, asiento de la emocionalidad y la memoria afectiva; y la neocorteza, responsable del lenguaje, el razonamiento abstracto y la planificación.

Cabe señalar, con la honestidad académica que exige este comité, que la neurociencia evolutiva contemporánea ha cuestionado fuertemente la validez literal de este modelo como secuencia evolutiva real, al demostrar que estructuras homólogas y complejas existen en cerebros de reptiles y otros vertebrados no mamíferos. No obstante, su vigencia como herramienta heurística persiste en la literatura clínica del trauma, incluyendo textos de referencia como *El cuerpo lleva la cuenta* de Van der Kolk (2014), precisamente porque ofrece una imagen intuitiva y clínicamente útil de por qué, ante una amenaza, las estructuras subcorticales "más antiguas" dominan la respuesta por encima de la neocorteza reflexiva. Un ejemplo de fácil asociación a la vida diaria es cuando un conductor frena bruscamente al ver a un peatón cruzar de forma inesperada, el pie ya presionó el freno antes de que la persona pueda articular conscientemente el pensamiento "hay alguien cruzando la calle", bajo la lógica del modelo de MacLean, esto ejemplificaría cómo las estructuras subcorticales "más primitivas" ejecutan la respuesta defensiva antes de que la neocorteza complete su análisis reflexivo.

Esta dominancia subcortical, sin embargo, no opera en el vacío, se articula a través del propio cuerpo. El neurocientífico Antonio Damasio, a partir de su trabajo clínico con pacientes con lesiones en la corteza prefrontal ventromedial (CPFvm), individuos que conservaban intacta su capacidad de razonamiento lógico abstracto,

pero que tomaban decisiones catastróficas en su vida cotidiana, formuló en 1994 la hipótesis del marcador somático. Esta propuesta sostiene que las decisiones humanas, particularmente aquellas tomadas bajo incertidumbre o riesgo, no dependen exclusivamente del cálculo y análisis racional, sino que están guiadas por señales corporales, cambios en la frecuencia cardíaca, la sudoración, la tensión muscular, asociadas a través del aprendizaje emocional previo a experiencias pasadas de recompensa o de castigo. Estos "marcadores" actúan como un sistema de alarma o de aprobación somática que orienta la conducta de forma rápida, muchas veces antes de que el individuo pueda verbalizar por qué una opción le genera rechazo o confianza. Por ejemplo, una persona que fue traicionada por un antiguo socio de negocios puede sentir una opresión en el pecho o una incomodidad difusa al momento de firmar un nuevo contrato, incluso cuando no logra identificar conscientemente ninguna razón lógica de desconfianza hacia la nueva contraparte. Ese malestar corporal es, bajo la hipótesis de Damasio, un marcador somático operando de forma anticipada a la deliberación racional.

La evidencia empírica más citada en favor de esta hipótesis proviene del paradigma experimental conocido como Iowa Gambling Task, en el cual los participantes sanos comenzaban a evitar intuitivamente las decisiones desventajosas, anticipadas por respuestas fisiológicas de la piel, antes de poder explicar racionalmente por qué lo hacían, mientras que los pacientes con daño en la CPFvm persistían en elecciones ruinosas pese a comprender conscientemente el patrón (Bechara, Tranel & Damasio, 1997). No obstante, y en aras del rigor que exige este comité, es necesario señalar que esta interpretación ha sido objeto de debate: Maia y McClelland (2004), al utilizar métodos de evaluación más sensibles, encontraron que los participantes en realidad poseían un conocimiento explícito de la estrategia ventajosa considerablemente mayor al que se había asumido, lo cual cuestiona si el efecto responde genuinamente a marcadores somáticos inconscientes o a un aprendizaje cognitivo más consciente de lo que la hipótesis original planteaba.



Por otro lado, el neurocientífico Joseph LeDoux, en su obra *The Emotional Brain* (1996), ofreció el modelo que permite comprender con mayor precisión anatómica cómo un estímulo amenazante llega a desencadenar una respuesta de miedo, al identificar dos rutas neuronales paralelas que procesan la información sensorial desde el tálamo hasta la amígdala. La primera, denominada vía corta o "vía baja" (low road), transmite la información directamente del tálamo sensorial a la amígdala en cuestión de milisegundos, sin pasar por la corteza cerebral. Se trata de una vía rápida pero imprecisa, LeDoux la describió como una conexión "rápida y sucia", que genera una evaluación tosca del estímulo como potencialmente peligroso y activa de inmediato una respuesta defensiva. La segunda, la vía larga o "vía alta" (high road), conduce la misma información sensorial a través del tálamo hacia la corteza sensorial, donde es procesada con mayor detalle y precisión, antes de llegar finalmente a la amígdala para refinar, confirmar o inhibir la respuesta inicial ya desencadenada por la vía corta.

Esta arquitectura dual explica un fenómeno que resulta clínicamente relevante para el tópico tratado en el comité: la posibilidad de que el cuerpo reaccione defensivamente ante un estímulo que, tras el análisis cortical más detallado, resulta ser inofensivo. Cabe señalar, además, que el propio LeDoux ha refinado su postura en años posteriores, precisando que ni siquiera la vía larga opera de manera consciente en su tramo inicial, y proponiendo distinguir con mayor rigor entre los circuitos subcorticales de defensa y la experiencia subjetiva y consciente del miedo como sentimiento, la cual emergería de un procesamiento cortical superior y exclusivamente humano (LeDoux, 2012). Esta precisión es valiosa porque evita la simplificación de equiparar automáticamente "activación de la amígdala" con "sentir miedo conscientemente", distinción que resulta clínicamente relevante al evaluar respuestas disociativas donde el cuerpo reacciona defensivamente sin que la persona logre identificar o nombrar la emoción correspondiente. El propio LeDoux popularizó el ejemplo de caminar por un sendero y saltar hacia atrás, con el corazón acelerado, al ver algo alargado y curvo entre la hierba, para descubrir un segundo después, gracias al procesamiento más detallado de la vía larga, que se trataba únicamente de una manguera de jardín. El sobresalto y el salto físico ya ocurrieron, ejecutados por la vía corta, antes de que la vía larga pudiera corregir la evaluación inicial.

Todo lo anteriormente expuesto funge como un preámbulo fundamental a la comprensión de cómo el sistema nervioso reacciona ante la ruptura de su homeostasis neurobiológica gracias al trauma complejo. Sin embargo, para trasladar esta fundamentación al ámbito puramente clínico, es necesario comprender que este colapso no ocurre en el vacío, sino que atraviesa la totalidad

del individuo: su cuerpo, su memoria, su identidad y el relato que construye sobre sí mismo. Comprender cabalmente el trauma complejo exige, por tanto, reconstruir la genealogía intelectual que ha intentado explicar, durante más de un siglo, cómo reacciona la psique humana ante aquello que la desborda. Esta historia, como se evidenciará, no es lineal ni acumulativa: es una historia de hallazgos brillantes, resistencias institucionales y olvidos prolongados, que solo comienza a consolidarse como campo científico unificado hacia finales del siglo XX.

El punto de partida se ubica en el Hospital de la Salpêtrière de París, donde el neurólogo Jean-Martin Charcot fue el primero en abordar desde una perspectiva científica moderna la histeria, una enfermedad que afectaba exclusivamente a las mujeres. Impartió clases a sus estudiantes de medicina, mostrándoles fotografías y casos reales, sobre los síntomas de la histeria que, según él, eran causados por una lesión interna desconocida que afectaba al sistema nervioso. Charcot ante un



"Une leçon clinique à la Salpêtrière" célèbre peinture al óleo de Andre Brouillet en 1887, donde se visualiza una sesión de hipnosis pública de Charcot contra la histeria en el Hospital de la Salpêtrière en Paris.

auditorio compuesto por médicos, escritores y curiosos de la alta sociedad parisina, realizaba hipnosis públicamente a sus pacientes, para inducir y luego suprimir, ante los ojos de los asistentes, síntomas neurológicos completos: parálisis de extremidades, convulsiones, pérdidas de la visión o del habla, sin que existiera lesión orgánica alguna que los explicara.

Es así que aunque Charcot enmarcó estos hallazgos dentro de una hipótesis hereditario-degenerativa hoy completamente descartada, su aporte fundamental para el campo que hoy ocupa a este comité fue demostrar, de manera pública y reproducible, que una idea o una emoción podía producir un síntoma físico real, sin necesidad de una causa orgánica. A modo ilustrativo, pensemos en una persona que, tras un accidente automovilístico del cual salió físicamente ilesa, comienza días después a experimentar parálisis parcial en los miembros inferiores sin ninguna lesión neurológica detectable. Este es, en esencia, el tipo de fenómeno, que hoy es comprendido bajo el nombre de trastorno de síntomas neurológicos



funcionales, que Charcot documentó de forma pionera hace más de 140 años y que representa un antecedente clave de estudiar a la hora de hablar sobre el trauma.

De este modo, fué en este laboratorio clínico donde germinaron, casi simultáneamente y a partir del mismo maestro, las dos teorías que definirían el estudio del trauma psíquico durante el siglo siguiente: la de su discípulo directo, Pierre Janet, y la de un joven neurólogo vienés que asistió a sus lecciones durante una estancia en París, quien sería el padre de la corriente psicoanalítica, Sigmund Freud (ohh prende dos prende dos).

En 1889, Pierre Janet, invitado por el propio Charcot a dirigir el laboratorio de psicología de la Salpêtrière, publicó *L'automatisme psychologique*, considerado por la literatura contemporánea como el primer tratado sistemático sobre disociación de la historia de la psicología clínica. Janet propuso que, ante una experiencia que desborda la capacidad de asimilación consciente del sujeto, dicha experiencia queda registrada como una "idea fija" (*idée fixe*): un conjunto de recuerdos, sensaciones y emociones que se escinden del flujo normal de la conciencia, lo que Janet denominó *désagrégation psychologique*, y que continúan operando de manera autónoma, fuera del control voluntario del individuo.

El caso clínico que Janet consideró el más representativo de toda su obra, y al que regresó repetidamente en sus publicaciones entre 1904 y 1928, fue el de su paciente Irène, una joven de 23 años que había cuidado en solitario a su madre moribunda durante meses, en condiciones extremadamente penosas, hasta presenciar su muerte. Tras el fallecimiento, Irène desarrolló una amnesia completa respecto a la enfermedad y muerte de su madre: era incapaz de recordar conscientemente el suceso. Sin embargo, de forma periódica, entraba en crisis disociativas durante las cuales reactuaba de manera completa e idéntica la noche de la muerte: hablaba con el cadáver, intentaba reanimarlo, repetía frases textuales pronunciadas esa noche, todo ello con extraordinario detalle sensorial, para luego, al recuperar la conciencia ordinaria, no conservar ningún recuerdo de haber tenido la crisis.

Janet observó así un fenómeno crucial que anticipa en más de un siglo la comprensión contemporánea del trauma: la memoria traumática no se olvida en sentido estricto, sino que permanece disociada de la conciencia narrativa ordinaria y se reactiva de forma sensorial y automática, en lugar de integrarse como un recuerdo biográfico con principio, desarrollo y fin (van der Hart y Piedfort-Marin, 2023). Janet logró, mediante hipnosis, ayudar a Irène a "realizar", término que él mismo acuñó, la muerte de su madre, es decir, a integrarla conscientemente como



parte de su historia personal, tras lo cual las crisis de reactivación cesaron por completo.

Es exactamente este mecanismo el que explica, más de un siglo después, por qué un veterano de guerra puede arrojarse instintivamente al suelo al escuchar un fuego artificial, o por qué una sobreviviente de abuso puede congelarse por completo ante un perfume o un tono de voz específico, sin lograr articular conscientemente por qué reacciona así: el cuerpo "recuerda", reaccúa, aquello que la mente consciente no ha logrado integrar como relato.

Ese mismo periodo, Sigmund Freud y su colega Josef Breuer documentaron el caso que sentaría una base considerable del psicoanálisis: el de Bertha Pappenheim, conocida en la literatura clínica bajo el seudónimo de "Anna O.". Entre 1880 y 1882, mientras cuidaba a su padre moribundo, Pappenheim desarrolló un cuadro severo de parálisis en tres extremidades, alteraciones visuales, dos estados de conciencia alternantes que ella misma describía como su "yo malo" y su "yo bueno", y episodios en los que perdía por completo la capacidad de hablar su lengua materna, el alemán, pudiendo comunicarse únicamente en inglés. Breuer descubrió, casi por accidente, que al permitir que la paciente verbalizara bajo hipnosis el recuerdo específico asociado a cada síntoma, el síntoma correspondiente desaparecía. Un ejemplo célebre: Pappenheim había desarrollado una intensa hidrofobia, siendo incapaz de beber agua durante semanas pese a la sed extrema, al recordar bajo hipnosis el asco que había sentido, meses atrás, al ver a un perro beber de un vaso, el síntoma desapareció de inmediato.

A partir de estas observaciones, publicadas en 1895 en Estudios sobre la histeria, Freud y Breuer propusieron un mecanismo distinto al de Janet: para ellos, el síntoma histérico no era producto de un fracaso pasivo de integración, sino de un mecanismo de defensa activo e inconsciente, la represión (*Verdrängung*, en alemán), mediante el cual la psique expulsaba de la conciencia un afecto o recuerdo intolerable, el cual, al no poder descargarse, se "convertía" en un síntoma corporal. Esta distinción entre el modelo de Janet (disociación como falla estructural de integración, producto del agotamiento de la energía psíquica) y el de Freud (represión como defensa activa contra un contenido inconsciente) constituyó una bifurcación teórica que define, hasta el día de hoy, dos tradiciones distintas dentro del estudio del trauma, y que este comité deberá tener presente al analizar los expedientes clínicos: buena parte de la literatura contemporánea sobre disociación estructural (van der Hart, Nijenhuis, Steele, Spiegel) se reclama heredera directa de la tradición janetiana, mientras que buena parte del vocabulario clínico cotidiano ("represión", "negación", "resistencia") proviene de la tradición freudiana, es aquí donde entra su responsabilidad como especialistas y profesionales



investigar las determinadas corrientes con las cuales converge el cargo que estén representando, ya que con este ejemplo nos queda más que claro el cómo un mismo fenómeno puede analizarse desde paradigmas y posturas epistemológicas diferentes.

Continuando con la línea cronológica, fué Anna Freud, hija de Sigmund Freud, quien en 1936, en su obra *El yo y los mecanismos de defensa* sistematizó por primera vez el conjunto de estrategias inconscientes mediante las cuales el aparato psíquico se protege de un afecto, pensamiento o percepción intolerable. De ese extenso catálogo, los siguientes resultan especialmente relevantes para el análisis de trauma complejo que realizará el comité: la represión (exclusión activa de un contenido doloroso), la negación (rechazo a admitir la realidad de un hecho perturbador), la disociación (desconexión entre pensamiento, emoción y memoria de un evento) y, de particular relevancia clínica, la identificación con el agresor.

Este último mecanismo resulta de sumo interés, porque su historia ilustra perfectamente el patrón de "amnesia episódica" que caracteriza a todo este campo de estudio. El término fue acuñado en 1932 por Sándor Ferenczi, discípulo y colega cercano de Freud, en su célebre ponencia *Confusión de lenguas entre los adultos y el niño*, presentada en el Congreso Internacional de Psicoanálisis de Wiesbaden, Ferenczi describió cómo un niño víctima de abuso, incapaz de huir o de defenderse físicamente, termina por interiorizar la culpa del agresor y por anticipar automáticamente sus deseos, como una estrategia paradójica de supervivencia psíquica ante un terror del cual no puede escapar (Ferenczi, 1933/1980). Ferenczi insistió, además, en que un número considerable de los relatos de abuso de sus pacientes correspondía a hechos reales y no a fantasías infantiles. La propuesta de Ferenczi fue recibida con fuerte resistencia por la comunidad psicoanalítica de su época y permaneció marginada durante décadas, hasta que fue recuperada por la literatura contemporánea sobre trauma complejo como uno de sus antecedentes más lúcidos.

Por ejemplo, un menor que crece en un hogar con violencia intrafamiliar puede, con el tiempo, comenzar a anticipar y justificar el comportamiento agresivo de su cuidador, adoptando incluso frases o actitudes del agresor hacia otros miembros de la familia. Bajo el concepto de Ferenczi, esto no sería una simple imitación conductual aprendida, sino una estrategia psicológica profunda de supervivencia ante un peligro del cual el niño no puede escapar por medios convencionales.



Resulta valioso contrastar la tradición psicoanalítica recién expuesta con un paradigma epistemológicamente distinto, que llegó a conclusiones convergentes por un camino completamente diferente: la psicología humanista de Carl Rogers. Rogers postuló que todo organismo posee una tendencia actualizante: una motivación innata hacia el mantenimiento, el crecimiento y el despliegue del propio potencial. A partir de la interacción con el entorno, y particularmente de la evaluación recibida de otros significativos durante la infancia, el individuo desarrolla un autoconcepto: una estructura organizada y relativamente estable de percepciones sobre quién es. El bienestar psicológico, para Rogers, depende de la congruencia entre la experiencia orgánica (lo que el sujeto efectivamente vive y siente) y ese autoconcepto.

El problema surge cuando una experiencia resulta radicalmente incongruente con el autoconcepto ya formado, como ocurre de manera paradigmática en el trauma complejo, donde la vivencia de victimización choca frontalmente contra esquemas previos de seguridad, valía o confianza. Ante esta amenaza, Rogers propuso que el organismo despliega únicamente dos mecanismos defensivos: la negación, que consiste en excluir la experiencia amenazante de la conciencia por completo, y la distorsión perceptual, que consiste en reinterpretar dicha experiencia de forma que resulte compatible con la imagen que el sujeto tiene de sí mismo.

Cuando estos mecanismos se ven desbordados por la magnitud o persistencia de la amenaza (como suele ocurrir en la exposición prolongada al trauma), Rogers advertía que la conducta del individuo podía volverse desorganizada, oscilando de forma inconsistente entre la experiencia orgánica real y la estructura fracturada del autoconcepto. Por ejemplo, una persona que sostiene un autoconcepto de "buena hija" o "buen empleado" puede, tras sufrir maltrato prolongado por parte de una figura de autoridad, negar por completo la gravedad de lo vivido ("no fue para tanto"), o bien distorsionar perceptualmente el evento atribuyéndose la responsabilidad ("seguramente yo hice algo para merecerlo"), precisamente para preservar una imagen de sí misma que la experiencia vivida amenaza con destruir.

Esta convergencia resulta reveladora: dos tradiciones teóricas que partieron de supuestos filosóficos casi opuestos (el psicoanálisis, centrado en el conflicto pulsional inconsciente, y el humanismo, centrado en la tendencia natural hacia el crecimiento) coincidieron en identificar que la psique humana se defiende activamente de aquello que amenaza la coherencia de su identidad, y que dicha



defensa, cuando la amenaza es suficientemente severa o prolongada, puede terminar por fracturar la estructura misma que pretendía proteger.

El siguiente hito relevante llega con la Primera Guerra Mundial, cuando el psicólogo británico Charles Myers acuñó en 1915 el término shell shock para describir el cuadro de parálisis, mutismo y terror persistente que presentaban los soldados expuestos al fuego prolongado de artillería, inicialmente atribuido (de forma errónea) a microlesiones cerebrales causadas por las ondas expansivas de los proyectiles. Décadas después, tras años de trabajo clínico con veteranos de ambas guerras mundiales en un hospital de veteranos de Nueva York, el psicoanalista Abram Kardiner publicó en 1941 *The Traumatic Neuroses of War*, obra que la mayoría de los historiadores del campo consideran el antecedente teórico más directo del diagnóstico contemporáneo. Kardiner propuso el concepto de "fisioneurosis": una alteración persistente y psicobiológica del sistema nervioso autónomo tras la exposición al combate, caracterizada por hiperactivación crónica, respuestas de sobresalto exageradas, evitación deliberada de recordatorios del trauma y una marcada constricción de la personalidad y de la capacidad de proyectarse hacia el futuro. Leídos hoy junto a los criterios diagnósticos del DSM-5, los síntomas descritos por Kardiner en 1941 resultan asombrosamente coincidentes.

Fue precisamente la confluencia de dos movimientos sociales aparentemente distantes, la organización de veteranos de la guerra de Vietnam, que exigían reconocimiento clínico de su malestar persistente, y el movimiento feminista, que documentaba sistemáticamente el impacto psicológico de la violación y la violencia doméstica, lo que impulsó, en 1980, la incorporación formal del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) al DSM-III, reconociendo por primera vez de manera oficial que un evento externo abrumador podía producir un cuadro psicopatológico específico y diagnosticable, independientemente de la vulnerabilidad previa del individuo que lo padecía.

Finalmente, la psiquiatra Judith Herman, en su influyente obra *Trauma and Recovery* (1992), realizó un ejercicio historiográfico que constituye, en sí mismo, una de las tesis centrales de todo este campo. Herman observó que los síntomas de las pacientes histéricas de Charcot y Janet en el siglo XIX, los de los veteranos de guerra estudiados por Kardiner, y los de las sobrevivientes de violencia doméstica y abuso sexual documentadas clínicamente en los años setenta, compartían un núcleo psicopatológico común, pese a haber sido estudiados en momentos históricos completamente distintos, por profesionales que en muchos casos ni siquiera tuvieron noticia del trabajo de sus predecesores. A partir de esta observación, Herman describió la historia del estudio del trauma como una historia de "amnesia



episódica": cada vez que la sociedad se ve forzada a reconocer el impacto psicológico de la violencia sistemática, ya sea por una guerra o por un movimiento social, un periodo de investigación florece, para luego caer nuevamente en el olvido institucional cuando el contexto político deja de sostener dicho reconocimiento.

Es en este contexto que Herman propuso formalmente el concepto de trauma complejo, para nombrar el cuadro clínico distintivo que emerge específicamente de la exposición prolongada, repetida e interpersonal, a diferencia del trauma de incidente único que había inspirado originalmente los criterios del TEPT en 1980, y que resulta, como veremos en la siguiente sección de esta guía, insuficientemente capturado por dichos criterios diagnósticos originales.

La evidencia expuesta a lo largo de este apartado, desde el modelo de procesamiento dual que explica la hiperactivación subcortical característica del trauma, pasando por la evolución histórica del concepto desde Charcot y Janet hasta Herman y van der Kolk, hasta la comparativa nosológica entre el DSM-5-TR y la CIE-11 y la evidencia sobre la influencia de factores genéticos que se expondrán en el siguiente apartado, converge en una misma conclusión: el trauma complejo es un fenómeno multideterminado que ningún marco teórico aislado logra capturar en su totalidad. Por ello, el comité exige a sus especialistas una lectura integradora de estas líneas de evidencia al argumentar sus impresiones clínicas, evitando privilegiar un único nivel de análisis (neurobiológico, histórico, nosológico o genético) por encima de los demás.

1.- COMPARATIVA DEL PANORAMA NOSOLÓGICO

Antes de comparar cómo cada sistema clasifica el trauma complejo, es indispensable entender qué es exactamente un manual de clasificación diagnóstica: se trata de un catálogo de criterios, redactado por comités de expertos, que le permite a cualquier profesional de la salud mental, en cualquier parte del mundo, nombrar un mismo cuadro clínico de la misma manera. Sin un lenguaje diagnóstico compartido, sería imposible comparar investigaciones entre países, coordinar tratamientos, o determinar qué cobertura de seguro médico corresponde a qué condición. Existen, sin embargo, dos manuales distintos que cumplen esta función a nivel mundial, publicados por organizaciones diferentes, con historias, alcances y procesos de elaboración distintos.

El DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) es publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría (no confundir, con la



Asociación Americana de Psicología que preside este comité). Su primera edición data de 1952; la versión vigente actualmente, el DSM-5-TR, fue publicada en marzo de 2022 como una revisión de texto del DSM-5 original de 2013, es decir, no introdujo cambios estructurales mayores, solo actualizaciones puntuales de criterios, prevalencias y terminología a la luz de nueva evidencia científica. El DSM es un documento comercial y su proceso de elaboración corre a cargo de grupos de trabajo internos de la propia Asociación Americana de Psiquiatría, compuestos mayoritariamente por especialistas de Estados Unidos. Es, con diferencia, el manual más utilizado en la práctica clínica, la investigación académica y los tribunales de ese país, y su influencia se extiende globalmente por la centralidad de la producción científica estadounidense en psicología y psiquiatría.

La CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades), en cambio, es publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y tiene un alcance considerablemente más amplio. Este no clasifica únicamente trastornos mentales, también abarca todas las enfermedades, lesiones y causas de muerte reconocidas en medicina, el trastorno mental es apenas uno de sus muchos capítulos. Su origen se remonta al siglo XIX, y su versión vigente, la CIE-11, fue adoptada por unanimidad en mayo de 2019 durante la 72.^a Asamblea Mundial de la Salud (el órgano que reúne a los ministros de salud de los 194 países miembros de la OMS), entrando oficialmente en vigor el 1 de enero de 2022. La CIE-11 es de acceso público y gratuito en línea, y su proceso de elaboración fue explícitamente diseñado para ser más colaborativo e internacional: participaron especialistas de más de noventa países a lo largo de más de una década de trabajo, con el objetivo declarado de mejorar su aplicabilidad clínica transcultural. Además, para los 194 Estados miembros de la OMS, el uso de la CIE no es opcional, es el estándar obligatorio para el reporte oficial de estadísticas de salud, mortalidad y morbilidad ante la organización.

Recopilando, el DSM-5-TR es el manual de una asociación profesional nacional, de uso predominante en Estados Unidos pero de influencia global, la CIE-11 es el instrumento de un organismo intergubernamental de 194 países, de uso administrativo obligatorio a nivel mundial. Ambos, sin embargo, funcionan de manera estructuralmente similar en lo esencial: definen los trastornos mediante listas de criterios sintomáticos que un paciente debe cumplir (un modelo llamado categorial, que exige o no exige un diagnóstico como si fuera un interruptor de encendido/apagado, en lugar de medir la severidad en una escala continua), y ambos se revisan periódicamente mediante grupos de trabajo de especialistas que evalúan la evidencia científica acumulada desde la edición anterior. Es precisamente en esa revisión periódica donde ambos manuales, enfrentados a la misma evidencia sobre el trauma complejo, tomaron caminos distintos.



En otro orden de ideas, es necesario notar que ambos manuales ya divergen en su definición del TEPT simple. Esta divergencia resulta fundamental para la consideración de los profesionales y para el trabajo del comité, dado que condiciona directamente cómo se aborda posteriormente el trauma complejo, categoría que, como se desarrollará más adelante, uno de los dos manuales ni siquiera reconoce de forma independiente.

Por un lado, El DSM-5-TR estructura el trastorno de estrés postraumático mediante ocho criterios consecutivos, identificados de la A a la H. El Criterio A exige la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenazada, y contempla cuatro vías posibles de exposición, la experiencia directa, la presencia directa del suceso ocurrido a otros, el conocimiento de que el suceso ocurrió a un familiar cercano o amigo íntimo, y la exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del evento, como ocurre en ciertas profesiones de riesgo (American Psychiatric Association, 2022, p. 271). El manual aclara explícitamente que las reacciones emocionales inmediatas, como el miedo, la impotencia o el horror, ya no forman parte de este criterio, cambio introducido respecto a ediciones anteriores. Los Criterios B, C, D y E desarrollan, respectivamente, los síntomas de intrusión, la evitación persistente, las alteraciones cognitivas y del estado de ánimo, y la alteración de la alerta y la reactividad, mientras que los Criterios F, G y H establecen los umbrales de duración, deterioro funcional y exclusión de causas fisiológicas (American Psychiatric Association, 2022, pp. 271-272).

Por su parte, la CIE-11, define al TEPT dentro de su capítulo de Trastornos Específicamente Asociados con el Estrés como un trastorno que puede desarrollarse tras la exposición a un evento o serie de eventos de naturaleza extremadamente amenazante u horrible. A diferencia de la estructura fragmentada del DSM-5-TR, la CIE-11 condensa el cuadro clínico en tres elementos nucleares que deben presentarse en conjunto, estos siendo: la revivencia del evento en el presente, la evitación deliberada de recordatorios, y la percepción persistente de amenaza actual, ejemplificada mediante hipervigilancia o una respuesta de sobresalto exagerada. El manual precisa además que reflexionar o rumiar sobre el evento, sin experimentarlo como si estuviera ocurriendo nuevamente, no resulta suficiente para satisfacer el requisito de revivencia, matiz que busca evitar la confusión clínica con la rumiación depresiva (World Health Organization, 2019/2021, entrada 6B40, sección "Diagnostic Requirements").

Considerando ambas definiciones, la diferencia más notoria radica en la exhaustividad de los criterios que proponen. El DSM-5-TR exige la presencia de al



menos ocho síntomas distribuidos en cuatro categorías: intrusión, evitación, alteraciones negativas de la cognición y el estado de ánimo, y alteración de la activación y reactividad, seleccionados de un listado de veinte síntomas posibles. La CIE-11, en cambio, adoptó deliberadamente un enfoque más sencillo: exige únicamente tres elementos nucleares (revivencia del trauma en el presente, no solo su recuerdo, evitación deliberada de recordatorios, y una sensación persistente de amenaza actual), priorizando la simplicidad diagnóstica y la utilidad clínica en contextos de atención primaria. (Brewin et al., 2017). Estas divergencias se extienden paralelamente a la duración mínima exigida, dado que el Criterio F del DSM-5-TR establece explícitamente que la alteración debe superar el mes de duración, mientras que la CIE-11 exige que el síndrome característico dure al menos varias semanas, formulación considerablemente menos precisa.

Una analogía útil es pensar en estos dos manuales como dos formularios distintos para diagnosticar lo mismo. El DSM-5-TR usa un formulario más largo: una lista de 20 síntomas posibles y pide marcar al menos 8 de ellos, repartidos en 4 grupos (recuerdos invasivos, evitar cosas que recuerden el estímulo traumático, pensamientos y ánimo negativos, y estar "a la defensiva" todo el tiempo). La CIE-11 usa un formulario más corto: solo pide 3 cosas: (revivencia del trauma como si estuviera pasando ahora, evitación a estímulos que hagan recordarlo, y sentimientos de que el peligro sigue presente).

La importancia radica en que cuando el trauma no fue un solo evento, sino a una experiencia sostenida en el tiempo como el abuso prolongado, el cautiverio o violencia constante, el daño psicológico resultante trasciende los síntomas nucleares del TEPT. En estos casos, la forma en la que la persona se percibe a sí misma y de relacionarse con otros quedan afectadas de manera considerablemente más profunda que en un cuadro postraumático convencional. A este cuadro más grave se le llama Trauma Complejo. La CIE-11 sí tiene una categoría oficial para esto, llamada TEPT Complejo.

A tal efecto, para alcanzar este diagnóstico, el manual exige que, además de los tres elementos nucleares que definen al TEPT convencional, la persona satisfaga tres condiciones adicionales, la incapacidad de regular adecuadamente sus emociones, la persistencia de creencias profundamente negativas sobre sí misma, y la dificultad marcada para sostener relaciones cercanas con otros (World Health Organization, 2019/2021, entrada 6B41, sección "Características esenciales"). El DSM-5-TR, en cambio, no contempla esta categoría de forma independiente. Lo único que ofrece en esa dirección es un especificador adicional aplicable al TEPT convencional, denominado con síntomas disociativos, que exige que la persona



experimente algo considerablemente más específico, la sensación de que su propio cuerpo no resulta real, conocida como despersonalización, o la sensación de que el entorno inmediato no resulta real, conocida como desrealización (American Psychiatric Association, 2022, p. 276).

El problema surge precisamente porque estos dos constructos no resultan equivalentes entre sí, y una misma persona puede satisfacer uno sin satisfacer el otro:

Alguien puede experimentar un daño profundo en su autopercepción, junto con una incapacidad marcada para confiar en los demás y una desregulación emocional persistente, cumpliendo así con el TEPT complejo bajo la CIE-11, sin experimentar en ningún momento la sensación de despersonalización o desrealización que exige el especificador del DSM-5-TR. Bajo este último manual, dicha persona recibiría únicamente el diagnóstico de un TEPT convencional, lo cual subestimaría considerablemente la complejidad real de su cuadro clínico. El fenómeno inverso resulta igualmente posible, una persona puede experimentar episodios recurrentes de despersonalización o desrealización, cumpliendo así con el especificador disociativo del DSM-5-TR, sin presentar el resto del daño emocional y relacional que la CIE-11 exige para diagnosticar formalmente el TEPT complejo.

TEPT simple y TEPT complejo bajo ambos manuales

Dimensión	TEPT bajo el DSM-5-TR	TEPT bajo la CIE-11 (6B40)	TEPT complejo bajo la CIE-11 (6B41)
Estructura de criterios	Ocho criterios, A a H, con mínimo ocho síntomas de veinte posibles entre los Criterios B a E .	Tres elementos nucleares, un síntoma requerido por cada uno.	Los tres elementos nucleares del TEPT más tres características esenciales adicionales.
Duración mínima	Superior a un mes, Criterio F.	Al menos varias semanas.	Al menos varias semanas, mismo umbral que el TEPT simple.
Reacción de sobresalto	Exagerada, Criterio E4.	Hipervigilancia o sobresalto exagerado.	Puede estar disminuida en lugar de aumentada, a diferencia del TEPT simple.
Regulación	No constituye criterio	No es criterio del TEPT	Característica esencial



afectiva	independiente, el Criterio E1 recoge irritabilidad y arrebatos de furia.	simple.	obligatoria, con ejemplos de reactividad emocional, arrebatos violentos y embotamiento.
Autoconcepto	El Criterio D2 recoge creencias negativas sobre uno mismo, sin constituir criterio independiente.	No es criterio del TEPT simple.	Característica esencial obligatoria, creencias de sentirse disminuido, derrotado o inútil.
Relaciones interpersonales	Tratadas dentro del diagnóstico diferencial con trastornos de la personalidad, no como criterio formal .	No es criterio del TEPT simple.	Característica esencial obligatoria, dificultad para mantener relaciones cercanas.
Límite con trastornos de la personalidad	Las dificultades interpersonales postraumáticas se atribuyen al TEPT y no a un trastorno de personalidad independiente.	No aplica directamente.	Reconoce superposición frecuente con trastornos de la personalidad, deja la doble asignación a criterio clínico.
Reconocimiento como categoría independiente	No reconocido, absorbido mediante el especificador disociativo y el diagnóstico diferencial.	No aplica.	Reconocido oficialmente bajo el código 6B41.

Nota. Elaboración propia. Sustentado en los criterios clínicos de ambos manuales.

2.- FACTORES GENÉTICOS EN LA EXPOSICIÓN Y DESARROLLO DE TRAUMA COMPLEJO

A lo largo de las últimas décadas, la investigación en psicología clínica ha reconocido que el trauma complejo no puede explicarse únicamente a partir de la intensidad o la cronicidad del evento adverso vivido por el paciente. Cada vez con mayor frecuencia, la literatura científica incorpora el componente genético como una variable adicional que participa en la manera en que el individuo se relaciona



con su entorno. Bajo esta perspectiva, la predisposición genética no actúa como una causa aislada del trastorno. En su lugar, actúa como un factor que puede modular tanto la vulnerabilidad del sujeto ante la adversidad como la propia probabilidad de verse expuesto a ella.

Esta línea de investigación se enmarca dentro de lo que la genética psiquiátrica denomina correlación gen-ambiente (rGE), concepto que describe la exposición no aleatoria a determinados entornos en función de la carga genética del individuo. Es importante subrayar, tal como lo hacen los propios investigadores del estudio que se expondrá a continuación, que este concepto no implica que la victimización infantil sea genéticamente determinada ni que la responsabilidad del maltrato recaiga sobre el menor que lo padece. Por el contrario, refleja que los riesgos de maltrato y acoso tienden a agruparse dentro de familias y contextos sociales particulares, y que los niños difieren entre sí en rasgos conductuales, emocionales y cognitivos que, al ser parcialmente heredables, pueden influir en cómo cuidadores y pares terminan tratándolos.

Con el propósito de profundizar empíricamente en esta discusión, Trotta et al. (2026) publicaron en la revista *Biological Psychiatry* la investigación titulada *Gene-Environment Correlation Across Trauma Subtypes and Developmental Timing: Evidence From the EU-GEI and ALSPAC*. El estudio constituye, según sus propios autores, el primer esfuerzo integral por examinar si la predisposición genética para distintos rasgos psiquiátricos y conductuales se correlaciona con la exposición a subtipos específicos de trauma infantil, diferenciando además el momento evolutivo en que dicha exposición ocurre. Para ello, los investigadores trabajaron con dos cohortes de gran tamaño, el estudio caso-control EU-GEI, centrado en pacientes con primer episodio psicótico reclutados en dieciséis sitios de seis países, y la cohorte de nacimiento británica ALSPAC, que sigue prospectivamente a miles de participantes desde su nacimiento hasta la adultez temprana. Ambas muestras permitieron contrastar la solidez del hallazgo bajo diseños poblacionales distintos y bajo métodos de medición diferenciados.



Siguiendo con este orden de ideas, la hipótesis central del estudio sostiene que la predisposición genética para distintos rasgos psiquiátricos y conductuales incrementa la probabilidad de que un individuo se exponga a formas específicas de trauma, particularmente durante la infancia temprana, cuando el menor cuenta con menor autonomía para modificar o escapar de su entorno inmediato. Los autores plantean, además, que esta correlación podría manifestarse con mayor fuerza en la niñez temprana que en la adolescencia, dado que las adversidades ocurridas dentro del núcleo familiar suelen reflejar con mayor fidelidad la carga hereditaria del entorno de crianza, mientras que las traumas ocurridos fuera del hogar durante la adolescencia dependerían en mayor medida de factores situacionales y grupales ajenos a la familia.

Así pues, los investigadores identifican tres posibles mecanismos teóricos que explicarían esta correlación, la rGE pasiva, en la cual los rasgos genéticamente influidos de los padres configuran el ambiente de crianza, la rGE evocativa, en la cual los rasgos propios del niño provocan determinadas respuestas por parte de adultos y pares, y la rGE activa, en la cual el propio individuo selecciona entornos congruentes con sus rasgos. No obstante, los autores aclaran desde el planteamiento inicial que el diseño del estudio no permite distinguir empíricamente entre estos tres mecanismos, por lo que la hipótesis se formula y se pone a prueba en términos de rGE definida de manera amplia, sin pretender aislar la vía específica que la produce.

Considerando lo anteriormente planteado, para evaluar esta hipótesis, los autores calcularon puntuaciones de riesgo poligénico mediante metodologías bayesianas de vanguardia, específicamente PRS-CS para participantes de ascendencia europea y su extensión multiancestral PRS-CSx para el resto de la muestra, generando puntuaciones estandarizadas para trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor, TDAH y neuroticismo como rasgos principales, además de trastorno por consumo de



cannabis, duración del sueño y trastorno del espectro autista como rasgos de sensibilidad. La muestra analítica de EU-GEI comprendió 1,191 participantes de ascendencia europea, con una edad media de 35 años y una distribución equilibrada entre 567 mujeres y 624 hombres. El trauma se evaluó de forma retrospectiva mediante la entrevista Childhood Experience of Care and Abuse y un cuestionario específico de acoso escolar, clasificando cada exposición como temprana, entre los 0 y los 11 años, o tardía, entre los 12 y los 17 años.

Por otro lado, en la cohorte ALSPAC, con 8,141 participantes, la medición del trauma combinó un enfoque prospectivo, recogido desde el nacimiento hasta los 17 años, con un autorreporte retrospectivo aplicado a los 22 años, lo cual permitió a los investigadores contrastar directamente ambos métodos de recolección dentro de un mismo diseño. Se aplicaron regresiones logísticas multinomiales para cada subtipo de trauma, ajustadas por sitio de estudio, edad, sexo y diez componentes principales de ascendencia genética, y se aplicó corrección por tasa de falsos descubrimientos mediante el método de Benjamini-Hochberg para controlar el error asociado a las comparaciones múltiples. Adicionalmente, los autores realizaron análisis de sensibilidad restringidos únicamente a los participantes control de EU-GEI, con el propósito explícito de reducir el riesgo de que las asociaciones observadas respondieran a una causalidad inversa derivada del propio diagnóstico psiquiátrico de los casos.

De este modo, en la cohorte EU-GEI, veinte asociaciones entre puntuaciones de riesgo genético y trauma sobrevivieron la corrección estadística, evidenciando el patrón más robusto para la puntuación de riesgo de estrés postraumático, la cual se asoció con abuso emocional temprano con una razón de momios de 3.37, abuso sexual temprano con 3.08, abuso físico temprano con 2.90 y acoso escolar temprano con 2.19. La puntuación de riesgo para trastorno bipolar mostró asociaciones con discordia doméstica temprana, abuso emocional temprano y acoso escolar tardío, mientras que la puntuación de esquizofrenia se vinculó con abuso emocional temprano, discordia doméstica temprana y acoso escolar tardío. La puntuación de



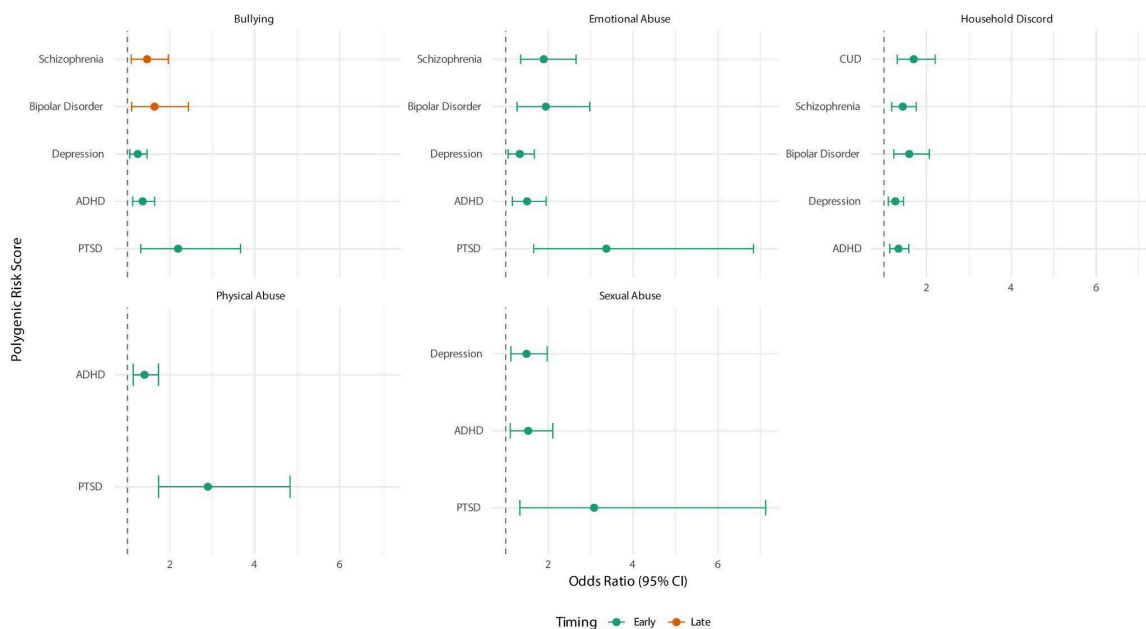
TDAH, por su parte, resultó la más ampliamente distribuida entre los subtipos de trauma, mostrando asociaciones significativas con abuso sexual, emocional y físico tempranos, así como con discordia doméstica y acoso escolar tempranos.

Bajo otro enfoque, al restringir el análisis únicamente a los participantes control de EU-GEI, con el fin de reducir el riesgo de causalidad inversa vinculada al diagnóstico psicótico, se mantuvieron siete asociaciones significativas, entre ellas la de estrés postraumático con abuso físico temprano, que incluso se fortaleció hasta alcanzar una razón de momios de 4.08. En la cohorte ALSPAC se replicaron veinte asociaciones adicionales, con un patrón de predominio similar en el trauma temprano y con efectos particularmente consistentes para las puntuaciones de TDAH, depresión y trastorno bipolar frente a violencia doméstica y abuso emocional. Cabe destacar, sin embargo, que la asociación con estrés postraumático, la más fuerte dentro de EU-GEI, no logró replicarse en ALSPAC, hallazgo que los propios autores atribuyen a diferencias en las características muestrales y en la severidad del trauma reportado, más que a la naturaleza prospectiva o retrospectiva de la medición.

En cuanto a la varianza explicada, esta resultó modesta en ambas cohortes, manteniéndose generalmente por debajo del dos por ciento cuando se consideraban únicamente las puntuaciones genéticas. No obstante, al combinar dichas puntuaciones con el antecedente familiar psiquiátrico, el ajuste del modelo mejoró de forma considerable, alcanzando entre un seis y un siete por ciento de varianza explicada para el caso específico de la discordia doméstica. Este hallazgo llevó a los autores a concluir que el antecedente familiar captura una porción de varianza que las puntuaciones poligénicas por sí solas no logran explicar, lo cual sugiere la existencia de vías genéticas y ambientales compartidas que actúan de manera conjunta.

Figura 1

Forest plot de las asociaciones significativas entre puntuaciones de riesgo poligénico (PRS) y subtipos de trauma en la muestra EU-GEI.



Nota. Reimpreso de "Gene-Environment Correlation Across Trauma Subtypes and Developmental Timing: Evidence From the EU-GEI and ALSPAC", por G. Trotta, I. Austin-Zimmerman y E. Spinazzola, 2026, *Biological Psychiatry*, 100(8), p. 641. Copyright 2026 por la Society of Biological Psychiatry.

La Figura 1 presenta un diagrama de bosque que agrupa las veinte asociaciones significativas entre las puntuaciones de riesgo poligénico y los distintos subtipos de trauma dentro de la cohorte EU-GEI, organizadas en cinco paneles según el tipo de adversidad, a saber, acoso escolar, abuso emocional, discordia doméstica, abuso físico y abuso sexual. Cada punto representa la razón de momios estimada para una combinación específica entre rasgo genético y trauma, mientras que las líneas horizontales indican el intervalo de confianza del noventa y cinco por ciento, y el color distingue si la asociación corresponde a exposición temprana o tardía. Al observar el conjunto, resulta evidente que la inmensa mayoría de los marcadores se concentran en verde, es decir, en la etapa temprana del



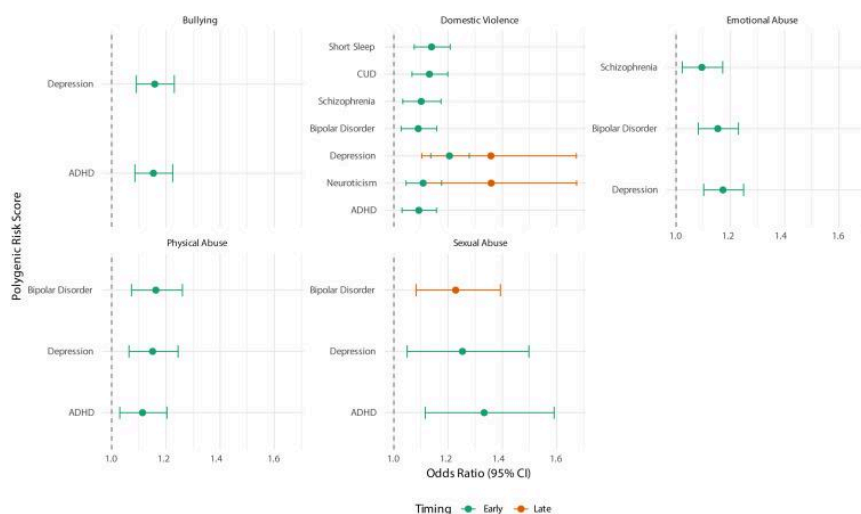
desarrollo, lo cual respalda visualmente la conclusión central del estudio sobre la especificidad evolutiva de la correlación gen-ambiente.

Dentro de este panorama general, el panel correspondiente al abuso sexual permite apreciar con claridad el hallazgo más robusto del estudio, la puntuación de riesgo para estrés postraumático se ubica considerablemente más alejada del valor nulo que cualquier otro marcador, con un intervalo de confianza amplio que, aun así, no cruza la línea de no asociación. Esta distancia visual respecto al resto de los puntos comunica de forma inmediata por qué los autores consideran este hallazgo el eje central de sus resultados. En contraste, los paneles de discordia doméstica y acoso escolar muestran una mayor densidad de marcadores agrupados cerca del valor uno, lo cual refleja asociaciones estadísticamente significativas pero de magnitud más modesta, correspondientes principalmente a esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno por consumo de cannabis.

En este sentido, los resultados demuestran que la fuerza de la correlación gen-ambiente no es homogénea entre los distintos rasgos psiquiátricos evaluados. Mientras que la puntuación de estrés postraumático concentra los efectos más amplios a través de múltiples subtipos de trauma, otros rasgos como el TDAH muestran una distribución más difusa pero igualmente extendida, apareciendo de forma reiterada en casi todos los paneles. Esta distinción visual refuerza el argumento de que la vulnerabilidad genética al trauma no opera de manera uniforme, sino que varía según el rasgo psiquiátrico considerado y según el tipo específico de adversidad enfrentada.

Figura 2

Forest plot de las asociaciones significativas entre puntuaciones de riesgo poligénico (PRS) y subtipos de trauma en la cohorte ALSPAC



Nota. Reimpreso de “Gene-Environment Correlation Across Trauma Subtypes and Developmental Timing: Evidence From the EU-GEI and ALSPAC”, por G. Trotta, I. Austin-Zimmerman y E. Spinazzola, 2026, *Biological Psychiatry*, 100(8), p. 641. Copyright 2026 por la Society of Biological Psychiatry.

La Figura 2 traslada la discusión desde la significancia estadística hacia la magnitud práctica del hallazgo, mostrando mediante gráficos de barras la varianza explicada, medida a través del Nagelkerke R cuadrado incremental, para tres tipos de modelo dentro de cada subtipo de trauma, el modelo que solo incluye la puntuación de riesgo poligénico, el que solo incluye el antecedente familiar psiquiátrico y el modelo combinado de ambos. Cada panel corresponde a un subtipo de trauma distinto, y dentro de cada uno las barras se agrupan por rasgo genético evaluado, permitiendo comparar directamente el aporte explicativo de la genética poligénica frente al del historial familiar.

Al revisar los cinco paneles, el patrón más consistente es que las barras verdes, correspondientes al antecedente familiar, superan de manera sistemática a las barras azules, correspondientes a la puntuación poligénica aislada, en casi todos los subtipos de trauma. Esta diferencia se vuelve especialmente notoria en el panel

de discordia doméstica, donde el modelo combinado de puntuación poligénica y antecedente familiar alcanza el valor más alto de toda la figura, cercano al siete por ciento de varianza explicada, muy por encima del escaso dos por ciento que logran las puntuaciones genéticas por sí solas en la mayoría de los paneles restantes.

Por consiguiente, esta figura cumple una función argumentativa distinta más complementaria a la anterior. Mientras que la Figura 1 demuestra que las asociaciones entre genética y trauma son estadísticamente reales, la Figura 2 obliga a matizar inmediatamente esa afirmación, mostrando que dichas asociaciones explican una porción comparativamente pequeña de la varianza total en la exposición al trauma. Le resultaría especialmente útil presentar ambas figuras en conjunto ante el comité, precisamente para evitar que los especialistas extraigan una conclusión determinista de la primera sin haber contemplado la magnitud real y modesta que revela la segunda.

A pesar de la solidez de los hallazgos, los autores reconocen de manera explícita cinco limitaciones principales dentro de su propia discusión. En primer lugar, señalan que la evaluación retrospectiva del trauma en EU-GEI introduce un riesgo de sesgo de memoria, particularmente para los eventos ocurridos en etapas tempranas de la vida, aunque matizan que el recuerdo subjetivo del trauma puede ser clínicamente significativo por sí mismo y que la evaluación retrospectiva no necesariamente compromete la validez del hallazgo. En segundo lugar, advierten que las categorías de temporalidad empleadas se restringieron a rangos etarios predefinidos que no lograron capturar la cronicidad, la severidad ni la acumulación de experiencias traumáticas a lo largo del tiempo, y que tampoco se incluyeron formas de adversidad como el abandono o la privación, aspectos que consideran relevantes para investigaciones futuras.

A lo anterior se suma que, los autores reconocen, en tercer lugar, que las puntuaciones de riesgo poligénico derivan de estudios de asociación de genoma completo y reflejan únicamente la susceptibilidad genética asociada a variantes



comunes, por lo cual pueden omitir variantes raras o estructurales que también influyen en el riesgo ambiental, y su poder predictivo permanece particularmente limitado fuera de poblaciones de ascendencia europea. En cuarto lugar, subrayan que la varianza explicada modesta indica que existen numerosos factores genéticos y no genéticos adicionales que contribuyen a la exposición al trauma, razón por la cual advierten explícitamente contra cualquier interpretación determinista de sus resultados. Finalmente, en quinto lugar, reconocen que las diferencias en el diseño de estudio, en la edad de evaluación y en el método de detección del trauma entre ALSPAC y EU-GEI limitan la comparabilidad directa entre ambas cohortes, a lo cual se suma que el diseño general del estudio no permitió distinguir entre los mecanismos pasivo, evocativo y activo de la correlación gen-ambiente.

IV. EL COMITÉ

1.- PROCEDIMIENTO PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE EXPEDIENTES

Por otra parte, la investigación del caso clínico se llevará a cabo a través de tres fases concatenadas:

- I. Al iniciar la sesión, la Mesa Directiva hará entrega de la *Ficha Clínica Inicial*. Este documento oficial consignará los datos demográficos básicos del paciente, su motivo de consulta, la sintomatología observable a primera vista y un breve historial del trauma conocido. A partir de este insumo, se abrirá la discusión para realizar un triaje inicial y formular las primeras hipótesis diagnósticas preliminares.
- II. En esta etapa, el comité profundiza en la evaluación diagnóstica.. Los especialistas pueden pedir información médica más avanzada a través de una moción. Aunado a ello, deben debatir qué datos necesitan exactamente y solicitarlos de forma formal a la Mesa. Para mantener el orden y una carga



de trabajo razonable, solo se permite abrir un máximo de dos anexos por sesión, lo que exige a los participantes una cuidadosa negociación para definir cuáles son las pruebas más prioritarias para el caso.

- III. Si el comité lo considera necesario para el diagnóstico diferencial, podrá solicitar el ingreso del paciente o de un testigo clave al estrado para un interrogatorio directo si se encuentra disponible la moción. La Mesa Directiva evaluará de forma estricta la viabilidad de esta fase, autorizándola únicamente si constata una sólida fundamentación teórica en las preguntas de los especialistas y si se garantiza que el estado emocional del paciente es apto para la evaluación.

Para orientar las solicitudes de la Fase II, la evidencia médica y el historial profundo del paciente han sido preestructurados y divididos en cuatro Anexos Oficiales, los cuales permanecen bajo la custodia de la Mesa hasta que sean habilitados y los especialistas voten su desclasificación:

<i>Anexo A</i> Reporte Neurobiológico y Respuestas Somáticas	La solicitud de este anexo se limita exclusivamente a mediciones neurofisiológicas, escáneres cerebrales y registros de somatizaciones físicas observadas.
<i>Anexo B</i> Evaluación de Disociación y Memoria	Este anexo comprende de manera estricta escalas estandarizadas como DES-II o SCID-D, junto con reportes de amnesia, desrealización y despersonalización.
<i>Anexo C</i> Perfil de Personalidad y Manejo Afectivo	Su alcance abarca únicamente inventarios psicométricos, pruebas proyectivas, análisis de mecanismos de defensa y evaluaciones de regulación emocional.
<i>Anexo D</i> Historial Sociofamiliar y Peritaje Forense	Esta categoría queda restringida a testimonios del entorno cercano, antecedentes sociofamiliares y peritajes judiciales de credibilidad.



- **Moción de Requerimiento de Evidencia Especializada:** Permite a un especialista solicitar formalmente a la Mesa la apertura y entrega de un Anexo Oficial específico (A, B, C o D). El especialista proponente especificar qué bloque de información requiere y justificar científicamente su relevancia y necesidad clínica para el avance del diagnóstico. Requiere una votación para ser procesada y está sujeta al límite de dos anexos por sesión.
- **Moción de Comparecencia Clínica:** Permite solicitar formalmente que el paciente bajo estudio, un familiar o experto externo que ingrese a la sala de sesiones para ser interrogado o evaluado directamente una vez la moción haya sido habilitada por la Mesa Directiva.
- **Moción para el Confinamiento del Expediente:** Faculta al comité someter a votación la suspensión temporal de un dato, prueba o testimonio del expediente sobre el cual recaigan sospechas fundadas de falsedad, manipulación deliberada por terceros o negligencia médica previa. Si se aprueba, el anexo queda bajo reserva y no podrá ser usado para sustentar el diagnóstico final hasta que sea validada o desmentida por el hallazgo de un nuevo anexo.

2.- DOCUMENTOS DEL COMITÉ

- **Documento de Posición Especializada (DPE)**

El Documento de Posición Especializada es el instrumento de preparación obligatorio que cada especialista debe presentar ante la Mesa Directiva antes del inicio del modelo. Su propósito es que el delegado demuestre, con antelación a las sesiones, el dominio de la corriente teórica del especialista real que representa, así como su capacidad de aplicar dicha corriente al análisis de un expediente clínico concreto, en línea con las facultades de análisis y recomendación que ejerce el comité bajo el marco de la Asociación Americana de Psicología. Al final de este apartado, se adjuntará una matriz con cada especialista asignado a determinados bloques, a cada bloque de especialistas se le asignará un estudio de caso determinado en el que



centrarán su DPE. El objetivo es que se logre plasmar un análisis riguroso del estudio de caso desde la perspectiva o paradigma adyacente a su corriente o área de trabajo del especialista al que representen. A continuación, se adjunta una recomendación de estructura para la redacción de DPE's:

1. Identificación del especialista y corriente representada: Breve reseña de los aportes teóricos y metodológicos de la corriente y área del especialista asignado, y de cómo dicha corriente aborda el trauma complejo.
2. Síntesis del expediente asignado: Resumen objetivo del caso, sin adelantar conclusiones diagnósticas.
3. Análisis clínico desde la corriente representada: Lectura del caso exclusivamente a través del marco teórico del especialista asignado: qué mecanismos, variables o patrones prioriza esa corriente, y qué evidencia del expediente los sustenta.
4. Cuadros nosológicos (DSM-5-TR y/o CIE-11) que la corriente representada consideraría más plausibles y aquellos que descartaría, con su justificación.
5. Recomendaciones finales: Lineamientos de intervención y, si corresponde, propuesta de ajuste a los criterios nosológicos vigentes, formulados a modo de recomendación técnica (nunca como diagnóstico definitivo) en ejercicio de las facultades consultivas que el comité reproduce de la APA.

BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 3	BLOQUE 4
Dr. Stefan Hoffman	Dra. Judith Lewis Herman	Dr. Daniel Siegel	Dr. Otto Kernberg
Dr. Thomas Insel	Dr. Onno Van Der Hart	Dra. Maria Yellow Horse Brave Heart	Dra. Nancy McWilliams
Dr. António Damásio	Dr. Peter Levine	Dr. Alfried Längle	Dr. Kirk Heilbrun
Dr. Lisa Feldman Barrett	Dr. Richard Schwartz		Dr. David Finkelhor



Bloque 1: Caso “Genie” Susan Wiley (1970)

Bloque 2: Caso Chris Costner Sizemore (1950)

Bloque 3: Caso Siegfried Sasson y el hospital de Craiglockhart (1917)

Bloque 4: Caso Daniel Paul Schreber (1903)

- **Documento de Consenso Clínico**

El Documento de Consenso Clínico es el instrumento de cierre que el comité debe entregar a la Mesa Directiva al término de la deliberación de cada expediente. A diferencia del Documento de Posición Especializada, de carácter individual y preparatorio, este documento es de autoría colectiva y recoge el resultado del debate efectivamente sostenido en sesión, integrando las distintas lecturas de bloque en una sola postura institucional del comité frente al caso.

Su función no es declarar un diagnóstico médico concluyente, sino consolidar asociaciones empíricas fundamentadas: establecer qué cuadros nosológicos resultan compatibles con la sintomatología del expediente, bajo qué evidencia, recomendaciones a los manuales nosológicos actuales (DSM V y CIE 11) enmarcados en el caso, y qué recomendaciones de abordaje se derivan de ello, en ejercicio de las facultades consultivas que el comité reproduce de la Asociación Americana de Psicología. El documento se redacta y entrega al cierre de la Fase III (o de la Fase II, si la Mesa Directiva no habilita la Moción de Comparecencia Clínica) correspondiente a cada expediente, antes de que el comité pase al siguiente caso.



PREGUNTAS CLAVE:

- ¿Qué condiciones políticas o sociales actuales podrían estar favoreciendo o silenciando el reconocimiento de nuevas formas de trauma complejo hoy en día?
- ¿Qué papel ha jugado la falta de poder social de las víctimas históricas del trauma, pacientes histéricas del siglo XIX, veteranos de guerra, sobrevivientes de violencia doméstica, en que sus síntomas tardaran tanto en ser tomados en serio por la ciencia?
- Si, como demuestra la investigación de Newson et al. (2021), más de la mitad de las personas con sintomatología clínicamente significativa no encajan en ningún trastorno aislado del DSM-5, ¿qué responsabilidad tienen los sistemas de clasificación diagnóstica ante quienes quedan fuera de sus categorías?
- ¿Es la búsqueda de una nosología "objetiva" y universal del trauma un objetivo científicamente alcanzable, o el trauma es, por naturaleza, una experiencia demasiado heterogénea para ser capturada por categorías cerradas?
- Si la investigación de Rachel Yehuda sugiere que el trauma severo puede dejar huellas epigenéticas transmisibles a la siguiente generación, ¿qué implicaciones éticas tendría integrar este hallazgo en la evaluación clínica de pacientes cuyos padres o abuelos fueron víctimas de trauma masivo?
- ¿Puede un diagnóstico verdaderamente "objetivo" del trauma prescindir de la neurobiología, o la evidencia cerebral corre el riesgo de reducir una experiencia profundamente subjetiva a un conjunto de correlatos biológicos?
- ¿Cómo debe un comité de especialistas manejar el desacuerdo genuino entre escuelas teóricas (psicoanalítica, humanista, cognitivo-conductual, neurobiológica) al construir un consenso clínico sobre un mismo caso?
- ¿Hasta qué punto la psicología funge como una herramienta de apoyo al individuo y se convierte en un arma silenciosa que solapa la opresión sistemática a través de la adaptación y habituación del sujeto a ambientes hostiles?



- Si el trauma complejo puede expresarse mediante lenguajes somáticos, espirituales o comunitarios ajenos a la tradición psiquiátrica occidental, ¿cómo puede un manual diagnóstico universal evitar imponer, sin darse cuenta, una cosmovisión cultural específica como si fuera neutral?
- ¿En qué medida el acto mismo de diagnosticar puede convertirse en una forma adicional de opresión sistémica, y en qué medida negarse a diagnosticar puede privar a una víctima de acceso a tratamiento, reconocimiento legal o reparación?
- ¿Dónde está el límite ético entre una intervención diagnóstica que empodera a la víctima al nombrar su experiencia, y una que la reduce a una etiqueta clínica que termina definiéndola?
- Considerando todo lo debatido en el comité, ¿es más urgente perfeccionar los criterios diagnósticos existentes, o repensar por completo el modelo categorial de diagnóstico psiquiátrico frente a fenómenos tan heterogéneos como el trauma complejo?

V. ANEXOS Y REFERENCIAS

GLOSARIO:

Procesos Defensivos y Disociativos

- 1) **Disociación:** pérdida experimentada de información o control sobre procesos mentales que normalmente están disponibles para la conciencia, la atribución al yo o el control voluntario. Incluye desconexión del yo o entorno, reexperimentación disociativa, lagunas de memoria y distorsiones sensoriales (Hyland et al., 2019; Fung et al., 2022).
- 2) **Despersonalización:** forma de disociación caracterizada por desconexión del sentido del yo; la persona se experimenta como extraña a sí misma, separada de su cuerpo o de sus propios procesos mentales (Hyland et al., 2019; Hyland et al., 2023).



- 3) **Desrealización:** forma de disociación caracterizada por desconexión del entorno; lo externo se percibe como irreal, distante, brumoso o artificial (Hyland et al., 2019; Fung et al., 2022; Hyland et al., 2023).
- 4) **Amnesia disociativa:** subtipo de disociación marcado por lagunas de memoria y conciencia no explicadas simplemente por olvido ordinario, especialmente en relación con experiencias traumáticas (Hyland et al., 2019; Fung et al., 2022).
- 5) **Evitación cognitiva / hiperracionalización:** estilo de procesamiento en el que la atención se desvía de la experiencia emocional y se concentra en detalles concretos, utilitarios o externos; en la literatura clínica sobre trauma, esto se aproxima al pensamiento orientado externamente (Preece & Gross, 2024; Morais et al., 2022).
- 6) **Alexitimia:** rasgo multidimensional de procesamiento emocional definido por dificultad para identificar sentimientos, dificultad para describirlos y estilo de pensamiento orientado hacia lo externo. No es un diagnóstico. Es un rasgo transdiagnóstico asociado a psicopatología y somatización (Luminet & Nielson, 2024; Preece et al., 2017; Morais et al., 2022).

Sintomatología y Conducta

- 1) **Aplanamiento afectivo:** disminución persistente de la experiencia subjetiva y/o de la expresión observable del afecto; en el trauma complejo se manifiesta principalmente como entumecimiento emocional, es decir, la incapacidad de sentir o una respuesta atenuada ante estímulos que normativamente generan afectividad (Hyland et al., 2019; Lavasani & Courtois, 2021; Ozdemir et al., 2025).
- 2) **Hiperactivación autonómica:** estado de activación fisiológica elevada mediado por los sistemas de respuesta al estrés; clínicamente se expresa como hipervigilancia, hiperalerta y una sensación persistente de amenaza inminente (Hyland et al., 2019; Lavasani & Courtois, 2021; Apicella et al., 2025).
- 3) **Respuestas de lucha, huida o congelamiento:** patrones defensivos innatos ante la percepción de amenaza; la evidencia clínica documenta una



secuencia jerárquica que prioriza el congelamiento, seguido de la huida y, en última instancia, la lucha (Lavasani & Courtois, 2021; Cavicchioli et al., 2026).

- 4) **Ideación somática y somatización:** focalización del malestar en el soma; la somatización implica la expresión o canalización del sufrimiento psicológico a través de síntomas corporales, vinculándose estrechamente con la alexitimia y las secuelas traumáticas (Morais et al., 2022; Preece et al., 2017; Fung et al., 2022).
- 5) **Labilidad emocional:** cambio rápido e intenso del estado afectivo derivado de una marcada desregulación emocional; se caracteriza por una hiperreactividad afectiva combinada con severas dificultades para modular la intensidad y la duración de la respuesta (Apicella et al., 2025; Cavicchioli et al., 2026).
- 6) **Autolesiones no suicidas (NSSI):** daño intencional del propio tejido corporal sin intención letal y por motivos no socialmente sancionados; operan funcionalmente como mecanismos de regulación afectiva, alivio del arousal, modulación sensorial, autopunición o comunicación indirecta del malestar (Coll-Oltra et al., 2026; Wang et al., 2024).
- 7) **Conductas de control hipervigilante:** patrones de escaneo, comprobación y monitorización persistente del entorno dirigidos a detectar peligros y anticipar daños; en contextos de trauma, se encuentran estrechamente ligadas al sentido actual de amenaza y a las respuestas de hiperalerta (Hyland et al., 2019; Wu et al., 2023; Hyland et al., 2023).
- 8) **Comportamientos de evitación fóbica y aislamiento social:** retirada activa de estímulos, situaciones o vínculos interpersonales que activen miedo, amenaza o sobrecarga; en el CPTSD suele manifestarse mediante la evitación sistemática de recordatorios traumáticos, desapego relacional y ruptura de vínculos bajo condiciones de estrés (Hyland et al., 2019; Maercker, 2021; Lavasani & Courtois, 2021).



REFERENCIAS:

American Psychological Association. (2017b). Ethical principles of psychologists and code of conduct (2002, amended effective June 1, 2010, and January 1, 2017). <https://www.apa.org/ethics/code/index.html>

American Psychological Association. (2017c). Multicultural guidelines: An ecological approach to context, identity, and intersectionality. <http://www.apa.org/about/policy/multicultural-guidelines.pdf>

American Psychological Association, Task Force on the Assessment of Trauma. (2025). Guidelines for psychologists in the assessment of psychological trauma in adults. <https://www.apa.org/about/policy/guidelines-psychological-trauma-adults.pdf>

Botelho, F., Bogdan, L., & Power, S. A. (2022). Re-engaging cultural differences: Culture, morality, trauma and the integration of non-Western migrants. *Current Opinion in Psychology*, 48. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101454>

Brand, B. L. (2024). The concise guide to the assessment of trauma-related dissociation. American Psychological Association.

Brewin, C. R., Cloitre, M., Hyland, P., Shevlin, M., Maercker, A., Bryant, R. A., Humayun, A., Jones, L. M., Kagee, A., Rousseau, C., Somasundaram, D., Suzuki, Y., Wessely, S., van Ommeren, M., & Reed, G. M. (2017). A review of current evidence regarding the ICD-11 proposals for diagnosing PTSD and complex PTSD. *Clinical Psychology Review*, 58, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.09.001>

Carlson, E. B., Palmieri, P. A., & Spain, D. A. (2017). Development and preliminary performance of a risk factor screen to predict posttraumatic psychological disorder after trauma exposure. *General Hospital Psychiatry*, 46, 25–31. <https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2016.12.011>

Cloitre, M., Garvert, D. W., Brewin, C. R., Bryant, R. A., & Maercker, A. (2014). Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: A latent profile analysis. *European Journal of Psychotraumatology*, 5(1). <https://doi.org/10.3402/ejpt.v5.25097>



Cook, J. M., & Newman, E. (2014). A consensus statement on trauma mental health: The New Haven competency conference process and major findings. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 6(4), 300–307. <https://doi.org/10.1037/a0036747>

Duchowny, K. A., Smith, A. K., Cenzer, I., Brown, C., Noppert, G., Yaffe, K., Byers, A. L., Perissinotto, C., & Kotwal, A. A. (2025). The prevalence of lifetime trauma and association with physical and psychosocial health among adults at the end of life. *Journal of the American Geriatrics Society*, 73(1), 123–135. <https://doi.org/10.1111/jgs.19209>

Eadie, E. M., & Briere, J. (2025). *Psychological assessment of adult posttraumatic states: Phenomenology, diagnosis, and measurement* (3rd ed.). American Psychological Association.

Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Koss, M. P., & Marks, J. S. (2019). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) study. *American Journal of Preventive Medicine*, 56(6), 774–786. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2019.04.001>

Galatzer-Levy, I. R., Huang, S. H., & Bonanno, G. A. (2018). Trajectories of resilience and dysfunction following potential trauma: A review and statistical evaluation. *Clinical Psychology Review*, 63, 41–55. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2018.05.008>

Galatzer-Levy IR, Bryant RA. 636,120 ways to have posttraumatic stress disorder. *Perspect Psychol Sci.* (2013). 8:651–62. [10.1177/1745691613504115](https://doi.org/10.1177/1745691613504115) [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

Haering, S., Kooistra, M. J., Bourey, C., Chimed-Ochir, U., Doubková, N., Hoeboer, C. M., Lathan, E. C., Christie, H., & de Haan, A. (2024). Exploring transdiagnostic stress and trauma-related symptoms across the world: A latent class analysis. *European Journal of Psychotraumatology*, 15(1). <https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2318190>

Herman, J. L. (1992). Complex PTSD: A syndrome in survivors of prolonged and repeated trauma. *Journal of Traumatic Stress*, 5(3), 377–391. <https://doi.org/10.1002/jts.2490050305>

Hinton, D. E., & Lewis-Fernández, R. (2018). Culture and trauma-related disorders. In F. J. Stoddard Jr., D. M. Benedek, M. R. Milad, & R. J. Ursano (Eds.), *Trauma- and stressor-related*



disorders (pp. 131–140). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/med9780190457136.003.0011>

Mandelli, L., Petrelli, C., & Serretti, A. (2015). The role of specific early trauma in adult depression: A meta-analysis of published literature. *European Psychiatry*, 30(6), 665–680.
<https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2015.04.007>

Nadal, K. L. (2018). *Microaggressions and traumatic stress: Theory, research, and clinical treatment*. American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000073-000>

Nagar, M., Nakash, O., & Westen, D. (2020). Unpacking childhood experiences of abuse: Can clinicians identify their patients' history of abuse? *Journal of Trauma & Dissociation*, 21(3), 396–408. <https://doi.org/10.1080/15299732.2020.1719264>

Nagata, D. K., Kim, J. H. J., & Gone, J. P. (2024). Intergenerational transmission of ethnoracial historical trauma in the United States. *Annual Review of Clinical Psychology*, 20(1), 175–200. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-080822-044522>

Simiola, V., Smothers, B., Thompson, R., & Cook, J. M. (2018). A national survey of trauma training in psychology internships. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 27(3), 309–322. <https://doi.org/10.1080/10926771.2017.1311977>

Spiegel, D., Lewis-Fernández, R., Lanius, R., Vermetten, E., Simeon, D., & Friedman, M. (2013). Dissociative disorders in DSM-5. *Annual Review of Clinical Psychology*, 9, 299–326. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185531>

Stanton, K. J., Denietolis, B., Goodwin, B. J., & Dvir, Y. (2020). Childhood trauma and psychosis: An updated review. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 29(1), 115–129. <https://doi.org/10.1016/j.chc.2019.08.004>

van der Kolk, B. A. (2014). *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. Viking.

Zimmerman M, Ellison W, Young D, Chelminski I, Dalrymple K. How many different ways do patients meet the diagnostic criteria for major depressive disorder? *Compr Psychiatry*. (2015). 56:29–34. [10.1016/j.comppsy.2014.09.007](https://doi.org/10.1016/j.comppsy.2014.09.007) [DOI] [PubMed] [Google Scholar]